IGOR FRADIQUE LEANDRO FERRAZ

Acesso e Qualidade dos Serviços do Sistema Único de Saúde na perspectiva dos usuários: um Estudo Transversal no Estado do Rio de Janeiro

2025

MACAÉ

IGOR FRADIQUE LEANDRO FERRAZ

Acesso e Qualidade dos Serviços do Sistema Único de Saúde na perspectiva dos usuários: um Estudo Transversal no Estado do Rio De Janeiro

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao Curso de Farmácia do Instituto de Ciências Farmacêuticas da UFRJ, como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Orientadora: Profa. Dra. Isabella Piassi Dias Godói

MACAÉ

2025

Igor Fradique Leandro Ferraz

Acesso e Qualidade dos Serviços do Sistema Único de Saúde na perspectiva dos usuários: um Estudo Transversal no Estado do Rio de Janeiro

Trabalho de conclusão de curso (TCC) defendido e aprovado como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Macaé, 16 de dezembro de 2025

Comissão avaliadora:

Prof. Dr. Isabella Piassi Dias Godói (Presidente da Banca)
CM UFRJ-Macaé
http://lattes.cnpq.br/9235375090080643

Prof. Dr. Thales Brandi Ramos
CM UFRJ-Macaé
http://lattes.cnpq.br/5501961270763349

Prof. Dr. Fernando de Castro Araujo Neto
CM UFRJ-Macaé
http://lattes.cnpq.br/3470305774624312

CIP - Catalogação na Publicação

F381
Ferraz, Igor Fradique Leandro
Acesso e qualidade dos serviços do Sistema Único de Saúde na perspectiva dos usuários: um estudo transversal no Estado do Rio De Janeiro / Igor Fradique Leandro Ferraz - Macaé, 2025.

66 f.

Orientador(a): Isabella Piassi Dias Godói.

Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Farmacêuticas, Bacharel em Farmácia, 2025.

1. Serviços de saúde. 2. Saúde pública. 3. Qualidade dos serviços de saúde. I. Godói, Isabella Piassi Dias, orient. II. Título.

CDD 615

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a)
Biblioteca Central do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé
Bibliotecário: Anderson dos Santos Guarino CRB7 – 5280

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, por todas as portas que me foram abertas e por me permitir chegar até esta conquista.

À minha família, em especial à minha mãe, por todo apoio incondicional. Dedico um agradecimento profundo à minha avó, que desde a infância despertou em mim o amor pela área da saúde; nasci e cresci vivenciando o SUS, e essa realidade foi fundamental para a minha escolha profissional.

Aos meus amigos Gabriel Santana, João Victor Corrêa, Pedro Henrique Pereira, Rhuan Gonçalves, Diego Assis e Davi Araujo. Deus me deu, muito mais que amigos, irmãos. Vocês se tornaram minha família e o apoio mútuo foi essencial para tornar esta jornada mais leve.

À minha namorada, Natália Monte, por ser meu pilar de apoio, paciência e incentivo ao longo de todo este percurso na faculdade. Sua compreensão foi fundamental para a conclusão deste trabalho.

Por fim, expresso minha imensa gratidão à minha orientadora, Prof.ª Dr.ª Isabella Piassi. Mais do que uma mentora, foi uma verdadeira "mãe" nesta universidade, guiando-me com sabedoria, acolhimento e dedicação.

A todos os mencionados, meu muito obrigado.

"*Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.*"

— *Paulo Freire (em Pedagogia do Oprimido)*

RESUMO

Este estudo aborda o Sistema Único de Saúde (SUS) em cinco regiões do estado do Rio de Janeiro, Brasil, um dos estados mais importantes do país, como parte de uma análise abrangente de um projeto de pesquisa que gerou publicações em fases anteriores. O objetivo foi avaliar as percepções dos usuários sobre o SUS em termos de acesso e qualidade dos serviços públicos de saúde, incluindo a atenção primária e os serviços farmacêuticos. Foi realizado um estudo transversal por meio de um questionário estruturado com 66 perguntas, aplicado a uma amostra intencional de 1000 participantes entre agosto de 2023 e agosto de 2024. Os dados foram analisados utilizando o teste Qui-quadrado de Pearson com o software R versão 4.3. Entre os participantes, 54,5% eram do sexo feminino, 62,5% tinham entre 26 e 60 anos, e 29% relataram possuir plano de saúde privado. Os serviços de vacinação foram os mais frequentemente utilizados pelo SUS (25,1% dos respondentes). Os participantes que relataram uso mais frequente dos serviços do SUS avaliaram o acesso de forma mais positiva do que aqueles que os utilizaram com menos frequência ($p = 0,002$). As regiões que avaliaram o acesso e a qualidade do SUS de forma mais favorável foram o Médio Paraíba e a Região Metropolitana, enquanto a região das Baixadas Litorâneas recebeu as avaliações mais negativas. Participantes com menor nível socioeconômico fizeram avaliações mais favoráveis do acesso aos serviços públicos de saúde ($p = 0,001$). Esses achados destacam preocupações sobre o acesso e a qualidade dos serviços de saúde do SUS e as disparidades regionais nas percepções dos usuários sobre os serviços no Rio de Janeiro. Os resultados ressaltam a importância da participação social como elemento-chave na avaliação e na melhoria contínua de um sistema de saúde público responsivo.

Palavras-chaves: Brasil; acesso; qualidade; serviços de saúde; usuários; saúde pública; avaliação da qualidade dos serviços de saúde

ABSTRACT

This study focuses on the Unified Health System (SUS) in five regions of the state of Rio de Janeiro, Brazil, one of Brazil's most important states, as part of a comprehensive analysis of a research project, which has generated publications in earlier phases. The objective was to assess users' perceptions of SUS in terms of access to and the quality of public health services, including primary care and pharmaceutical services. A cross-sectional study was conducted using a structured questionnaire comprising 66 questions, administered to a purposive sample of 1000 participants between August 2023 and August 2024. Data were analysed using Pearson's chi-square test with R software version 4.3. Among the participants, 54.5% were female, 62.5% were aged between 26 and 60 years, and 29% reported having private health insurance. Vaccination services were the most frequently used SUS service (25.1% of respondents). Participants who reported more frequent use of SUS services rated access more positively than those who used them less frequently ($p = 0.002$). The regions that evaluated SUS access and quality most favorably were Middle Paraíba and the metropolitan region, while the Coastal Lowlands region received the most negative assessments. Participants with lower socioeconomic status gave more favorable evaluations of access to public health services ($p = 0.001$). These findings highlight concerns about access to, and the quality of, SUS healthcare services and regional disparities in users' perceptions of SUS services in Rio de Janeiro. The results underscore the importance of social participation as a key element in the evaluation and continuous improvement of responsive public healthcare.

Keywords: Brazil; access; quality; health services; users; public health; healthcare quality assessments

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Serviços oferecidos pelo SUS 25
Figura 2 - Dificuldades relatadas pelos usuários ao tomar medicação 26
Figura 3 - Percepção de acesso e qualidade dos serviços do SUS por região 28

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Características dos participantes (n = 1000). 24

Tabela 2. Percepções dos usuários do SUS sobre a relevância, acesso e qualidade dos serviços públicos de saúde (n = 990). 27

Tabela 3. Visões dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos de saúde associadas à renda familiar (n = 990). 29

Tabela 4. Visões dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) sobre a aquisição de medicamentos em farmácias públicas (n = 497).
30

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACS Agente Comunitário de Saúde

APS Atenção Primária à Saúde

CAAE Certificado de Apresentação de Apreciação Ética

EMulti Equipes Multiprofissionais

ESB Equipe de Saúde Bucal

ESF Estratégia Saúde da Família

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica

PNAB Política Nacional de Atenção Básica

PNAUM Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos

PNI Programa Nacional de Imunizações

SUS Sistema Único de Saúde

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UBS Unidade Básica de Saúde

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **10**
2. OBJETIVOS **14**
2.1. Objetivo geral 14
2.2. Objetivos específicos 14
3. MÉTODOS **15**
3.1. Desenho do estudo 15
3.2. População e amostra 16
3.3. Instrumento de pesquisa 16
3.4. Coleta de dados 17
3.5. Análise de dados 18
3.6. Aspectos éticos 19
4. RESULTADOS **20**
4.1. Características dos participantes 20
4.2. Avaliações e percepções dos usuários do SUS 22
5. DISCUSSÃO **27**
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS **32**
7. REFERÊNCIAS **33**
8. APÊNDICE **40**

1. INTRODUÇÃO

A Constituição de 1988 foi um marco histórico para a saúde pública no Brasil, ao estabelecer, em seu Artigo 196, a saúde como um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado (Brasil, 1990a). Com a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, foram definidos princípios fundamentais para o sistema de saúde. Entre eles, destacam-se a universalidade, a integralidade, a organização hierárquica e a participação social (Brasil, 1990b). Paralelamente, foram introduzidas diretrizes essenciais para ampliar a diversidade de ações em saúde (Brasil, 1990a,b). De modo geral, o SUS representa uma importante conquista social e uma transformação significativa no cenário da saúde no Brasil, visando à melhoria do bem-estar da população (Brasil, 1990a,b ; OECD, 2021). A gestão desse sistema universal envolve recursos financeiros, logísticos e humanos distribuídos entre diferentes entes políticos e administrativos autônomos (federal, estadual e municipal). Nesse arranjo, os municípios são responsáveis por ofertar a maior parte dos serviços de saúde (Brasil, 1990a, 1990b). Essa estratégia de descentralização exige colaboração e cooperação para alinhar os serviços de saúde às necessidades locais (Silva *el al.,* 2022).

O SUS é organizado em diferentes níveis de atenção, com o objetivo de promover o uso racional dos recursos disponíveis, que vão desde a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Atenção Secundária até os serviços altamente complexos e especializados da Atenção Terciária (Brasil, 2010). Dentro dessa estrutura, a APS desempenha um papel central na promoção da saúde e na prevenção de doenças, reduzindo a morbimortalidade e atuando como a principal porta de entrada no sistema de saúde, além de funcionar como reguladora do acesso a serviços mais complexos, quando necessário (Elidio el al., 2024). Uma das iniciativas socialmente mais reconhecidas no âmbito do SUS é o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Desde sua criação em 1973, o PNI alcançou diversos marcos importantes, incluindo a erradicação da varíola e o controle de epidemias, como a da COVID-19 (Bousquat el al., 2021).

No Brasil, a composição das equipes de atenção primária segue as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Contudo, os municípios têm autonomia para estruturar suas equipes de acordo com as necessidades locais, desde que atendam aos padrões mínimos estabelecidos para a APS (Brasil, 2017). A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo padrão, com equipes compostas por médicos de família, enfermeiros, agentes

comunitários de saúde (ACS) e técnicos de enfermagem. Também é recomendado que os municípios incluam a Equipe de Saúde Bucal (ESB), formada principalmente por cirurgiões-dentistas e técnicos, bem como as Equipes Multiprofissionais (EMulti), que contam com profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais (Brasil, 2022). Embora a presença do farmacêutico não seja obrigatória nas EMulti, seu papel é fundamental nos serviços farmacêuticos para aprimorar a dispensação e o uso racional de medicamentos, o que beneficia diretamente as famílias atendidas pela APS (Peixoto el al., 2022).

Embora o SUS seja fundado no princípio do acesso universal e integral aos serviços para toda a população, aproximadamente 25% dos brasileiros possuem um plano de saúde privado (Brasil, 2024). Enquanto muitos beneficiários de planos de saúde têm sua cobertura custeada pelos empregadores, e não por pagamentos diretos (Souza Junior el al., 2021), uma das principais motivações para adquirir cobertura privada é a percepção de maior facilidade para agendar consultas com especialistas (IEPS, 2025). Um dos fatores centrais para isso são os atuais obstáculos enfrentados no acesso aos serviços do SUS, agravados pelo aumento da demanda (Economist Impact, 2023). Além disso, existem preocupações com a desigualdade na distribuição de recursos entre as diferentes regiões do Brasil para atender às necessidades não supridas, o que impacta diretamente na disponibilidade de serviços de saúde integrais (Dornas el al., 2024; Souza el al., 2024; Raimundo el al., 2025).

A participação social é um pilar fundamental para garantir que as necessidades e demandas da população sejam atendidas, refletindo os princípios basilares do SUS (Picorelli, 2019). No Brasil, a Lei nº 8.142/1990 estabelece a participação social como um dos alicerces desse sistema universal, destacando o valor do engajamento cidadão por meio de mecanismos como os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde na construção e no fortalecimento do SUS (Brasil 1990b; Raimundo el al., 2025). Outros países com sistemas públicos de saúde, como o Canadá (Health Canadians, 2025) e o Reino Unido (HS England, 2023), também incorporam a participação social como princípio essencial. A importância da opinião pública na melhoria dos sistemas de saúde orienta o planejamento do SUS (Vital Strategies 2025), reforçando a relevância de estudos que investiguem as perspectivas dos usuários para subsidiar futuras tomadas de decisão.

Para coletar dados e fomentar discussões sobre a avaliação de diferentes tipos de serviços de saúde pública no Brasil, o governo federal desenvolveu programas como a Pesquisa Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos (PNAUM), de 2013, que teve como objetivo avaliar, em nível nacional, o uso e a promoção do uso racional de medicamentos (Gadelha el al., 2016). Paralelamente, em 2011, foi criado o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), que avaliou o desempenho das equipes de saúde e a qualidade dos serviços oferecidos na atenção primária, visando à melhoria contínua do cuidado prestado à população (Fardousi el al., 2022). Esses programas pioneiros contribuíram para levantamentos voltados ao uso de medicamentos, por exemplo, uso de medicamentos por faixa etária, dificuldades enfrentadas, entre outros achados no país (Gadelha el al., 2016, Mengue el al., 2016, Mello el al., 2017, Protasio el al., 2017a, b; Farbousi el al., 2022), além de reflexões sobre a oferta de serviços de saúde pública (Gadelha el al., 2016, Mengue el al., 2016, Mello el al., 2017, Protasio el al., 2017a, b; Fardousi el al., 2022). Os programas utilizaram questionários como instrumentos de coleta de dados, que posteriormente serviram como referência para o desenvolvimento de novas pesquisas relacionadas a esses temas (Dornas el al., 2024; Souza el al., 2024; Raimundo el al., 2025).

Após a descontinuação dos programas mencionados entre 2015 e 2019, poucas publicações (Medeiros el al., 2024; Umane, 2025; Vital Strategies, 2025) e/ou estudos sobre esse tema no Brasil foram divulgados. Em 2024, foi publicada uma revisão sistemática que abordou os desafios da universalidade no SUS e avaliou o acesso e a qualidade dos serviços de saúde no país, incluindo oito estudos realizados antes de 2020 (Medeiros el al., 2024). Além disso, em abril de 2025, foi divulgado um inquérito, baseado em questionário digital com taxa de resposta de 4,7%, que contou com a participação de 2.458 indivíduos de diferentes regiões do Brasil, avaliando o acesso e a qualidade da Atenção Primária à Saúde. Esses estudos evidenciaram que os usuários que utilizam o SUS com maior frequência pertencem a grupos socialmente mais vulneráveis (Umane, 2025; Vital Strategies, 2025).

No entanto, diante do número limitado de publicações brasileiras que avaliam a percepção dos usuários sobre os serviços do SUS desde 2020 (Medeiros el al., 2024; Umane, 2025), das baixas taxas de resposta em estudos anteriores (Umane, 2025; Vital Strategies, 2025) e da restrição dessas pesquisas a tópicos específicos por exemplo, apenas serviços

farmacêuticos ou atenção primária, torna-se necessária a realização de investigações mais atualizadas que reflitam a importância da participação social na identificação das demandas e necessidades da população. Além disso, há necessidade de um enfoque mais abrangente sobre a percepção dos usuários em relação a diversos aspectos da saúde pública, abrangendo a atenção primária, os serviços farmacêuticos e os desafios relacionados ao acesso a serviços especializados. Ademais, o estado do Rio de Janeiro é uma região estratégica no Brasil devido à sua relevância turística, econômica e cultural, e enfrenta desafios particulares ligados ao acesso e à qualidade dos serviços do SUS (Campos, 2019).

Consequentemente, um projeto de pesquisa intitulado "Avaliação do Acesso e da Qualidade dos Serviços de Saúde Pública na Perspectiva do Sistema Único de Saúde" vem sendo desenvolvido desde 2023 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (Dornas el al., 2024; Souza el al., 2024; Raimundo el al., 2025). Entre as regiões e municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, fases anteriores do projeto já foram publicadas, incluindo análises realizadas na Baixada Litorânea (Souza el al., 2024), na Região Metropolitana (Raimundo el al., 2025) e em um município do Norte Fluminense (Dornas el al., 2024).

Este estudo concentra-se nas cinco das sete regiões do estado do Rio de Janeiro sendo elas: Região Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte Fluminense, Região Serrana e Médio Paraíba. A pesquisa buscou engajar a população por meio da realização de entrevistas presenciais em diversos locais de grande circulação nos municípios, tanto das regiões metropolitanas quanto do interior do estado, cada região foi escolhida pelos alunos que tinha como a sua moradia mais próxima desses locais, pois não tinha financiamento para poder contemplar a pesquisa. O objetivo deste trabalho é analisar as percepções dos residentes dessas cinco regiões em relação ao acesso e à qualidade do sistema público de saúde, incluindo a atenção primária e os serviços farmacêuticos. Além disso, o estudo procura evidenciar as disparidades observadas entre as cinco regiões do estado do Rio de Janeiro, associadas à oferta de serviços na Atenção Primária à Saúde, na Atenção Especializada e no setor farmacêutico. O estudo também explora os principais desafios enfrentados pelos usuários do SUS e suas percepções sobre o papel do farmacêutico nos serviços de saúde. Os achados podem servir de subsídio para orientar todos os grupos de atores estratégicos no Brasil quanto a possíveis formas de aprimorar os serviços no futuro.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral

Analisar as percepções dos moradores de cinco regiões do estado do Rio de Janeiro: sobre o acesso e a qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.2. Objetivos específicos

- Avaliar a percepção dos moradores das regiões da Baixada Litorânea, Norte Fluminense, Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba sobre serviços, em especial, da Atenção Primária e os serviços farmacêuticos.

- Destacar as disparidades observadas entre as cinco regiões avaliadas e potenciais reflexões sobre a temática em estudo.

3. MÉTODOS

3.1. Desenho do estudo

Foi conduzido um estudo transversal para avaliar as percepções de moradores de cinco regiões do estado do Rio de Janeiro: Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte Fluminense, Serrana e Médio Paraíba, sobre diferentes aspectos dos serviços do SUS. Como o estudo não possuía financiamento externo nem recursos financeiros para apoiar as entrevistas, foi utilizada uma amostragem por conveniência. Isso levou em consideração fatores como a facilidade de acesso e deslocamento dentro do município selecionado e a possibilidade de as entrevistas serem realizadas por estudantes de graduação, ou seja, em municípios onde residem e/ou têm familiares, que fazem parte da equipe do projeto de pesquisa.

De acordo com dados do IBGE, o estado do Rio de Janeiro tem aproximadamente 17 milhões de habitantes, divididos em nove regiões e 92 municípios (IBGE, 2022). Para este estudo, as regiões foram analisadas de acordo com a divisão político-administrativa em regiões de saúde. A Região Metropolitana (I e II) corresponde a 75,4% da população do estado e inclui 19 municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Seropédica, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá (Rio de Janeiro, 2020a, 2020b). Dentre estes, três municípios foram selecionados como amostra por conveniência intencional para este estudo: a capital do estado (Rio de Janeiro), São Gonçalo e Duque de Caxias. Juntos, eles representam 68,9% da população da região.

A região Norte Fluminense compreende 5,7% da população do estado e inclui 8 municípios: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra (Rio de Janeiro, 2020c). Para este estudo, Campos dos Goytacazes e Macaé foram selecionados como amostra por conveniência, representando 52,3% da população da região.

A região das Baixadas Litorâneas corresponde a 5,1% da população do estado e inclui 9 municípios: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema (Rio de Janeiro, 2020d). Os municípios de Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia foram escolhidos como amostra por conveniência, abrangendo 61,2% da população da região.

A região do Médio Paraíba representa 5,4% da população do estado e inclui 12 municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda (Rio de Janeiro, 2020d). Os questionários foram coletados em todos os municípios desta região.

A Região Serrana corresponde a 6,0% da população do estado e inclui 16 municípios: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Morais (Rio de Janeiro, 2020f). Nesse contexto, Nova Friburgo, Cantagalo e Cordeiro foram incluídos no estudo, representando 21,1% da população da região.

3.2. População e amostra

Segundo o IBGE, o estado do Rio de Janeiro possui aproximadamente 17 milhões de habitantes, distribuídos em nove regiões de saúde e 92 municípios. A amostra final contou com 1.000 participantes, distribuídos proporcionalmente às populações das regiões selecionadas, de forma a garantir representatividade regional (IBGE 2022).

Critérios de inclusão: indivíduos com 18 anos ou mais, residentes nos municípios participantes e que aceitaram assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os participantes que declararam nunca ter utilizado os serviços do SUS, especificamente para as análises sobre acesso e qualidade.

3.3. Instrumento de pesquisa

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido pela equipe do projeto com base em projetos anteriores do governo federal: o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) (Mello *el al.,* 2017, Protasio *et al* 2017a,b , Fardousi *el al.,* 2022) e a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM) (Gadelha *el al.,* 2016, Mengue *el al.,* 2016). Na fase de desenvolvimento, o foco foi na elaboração de perguntas simples, objetivas e de fácil compreensão, seguindo o perfil daquelas adotadas nos instrumentos citados anteriormente

(Mello *el al.,* 2017; Fardousi *el al.,* 2022) O questionário final consistiu em 66 perguntas, e o mesmo instrumento foi aplicado em todas as cinco regiões do estado do Rio de Janeiro incluídas neste estudo. Foram incluídos aspectos como dificuldades no uso de medicamentos, tipos de serviços públicos de saúde utilizados e percepções sobre o SUS e outras abordagens.

As 66 perguntas foram organizadas nas seguintes quatro seções: (A) Perfil Socioeconômico e Uso de Serviços de Saúde; (B) Condição Clínica; (C) Uso de Medicamentos; e (D) Percepções e Uso de Serviços Públicos de Saúde. É importante ressaltar que apenas os participantes que relataram usar os serviços do SUS responderam à Seção D (Etapa Dois: Avaliando as percepções dos usuários sobre o acesso e a qualidade dos serviços do SUS), enquanto as seções anteriores (A, B e C) foram preenchidas por todos os participantes (n = 1000).

A Seção D teve como objetivo explorar as percepções dos participantes sobre diferentes aspectos dos serviços do SUS. Ela incluiu várias perguntas relacionadas ao acesso e à qualidade dos serviços públicos de saúde, os tipos de serviços mais frequentemente utilizados, a necessidade de buscar atendimento de saúde em um município diferente do seu local de residência e outros tópicos relacionados. Além disso, incluímos perguntas que abordam o contexto farmacêutico, com ênfase particular no uso de medicamentos, nas experiências dos participantes com as instruções de uso dos medicamentos, na aquisição e uso de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) e em outros aspectos relevantes. Perguntas adicionais buscaram avaliar se os participantes compreendiam totalmente suas prescrições, incluindo instruções para o uso de antibióticos e polifarmácia.

Para aumentar a robustez do questionário, ele foi pré-testado com 30 indivíduos do município de Macaé (Região Norte Fluminense), próximo à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ-Macaé). Durante o pré-teste, confirmamos que nenhuma pergunta necessitava de modificação.

3.4. Coleta de dados

O tamanho da amostra foi calculado para estimar uma proporção com uma margem de erro máxima de aproximadamente 3% a um nível de confiança de 95%, assumindo o cenário de maior variabilidade (ou seja, quando a proporção da população é igual a 0,50). Isso

resultou em um tamanho de amostra estimado de aproximadamente n =1000 participantes, distribuídos entre os municípios proporcionalmente aos seus tamanhos populacionais (Althubaiti, 2022).

Como o projeto não tinha financiamento disponível, os municípios e regiões do estado do Rio de Janeiro com maior acessibilidade e viabilidade para a equipe de entrevistadores foram selecionados como uma amostra por conveniência intencional. Os critérios de inclusão exigiam que os participantes tivessem 18 anos de idade ou mais. Para as análises que avaliaram a qualidade dos serviços públicos de saúde, foram excluídos os indivíduos que relataram nunca ter utilizado o SUS.

A coleta de dados foi realizada por estudantes de graduação do Instituto de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro/Macaé, que foram previamente treinados pelo professor coordenador do estudo. As entrevistas ocorreram em áreas públicas e de livre acesso, geralmente próximas a estabelecimentos de saúde, incluindo farmácias municipais, hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Esses locais foram selecionados intencionalmente para maximizar o recrutamento de participantes que fossem usuários do SUS ou de planos de saúde privados, maximizando a inclusão de diversas experiências e perspectivas. Deve-se notar que os entrevistadores convidaram aleatoriamente indivíduos de vários locais de grande circulação em cada município selecionado, a fim de incluir participantes com diferentes perfis socioeconômicos. A estratégia de recrutamento visou abordar indivíduos que provavelmente tivessem contato recente ou contínuo com os serviços de saúde, especialmente aqueles presentes nos locais de saúde no momento da coleta de dados.

3.5. Análise de dados

A análise dos dados consistiu em uma avaliação descritiva das respostas dos participantes, incluindo questões sobre as características da amostra, como gênero, idade, nível de escolaridade, renda familiar e perfil clínico, que são apresentadas em tabelas e gráficos. Além disso, foram realizadas análises sobre os padrões de utilização e as percepções dos serviços públicos de saúde, com foco principal na Atenção Primária à Saúde (APS), e incluíram a atenção especializada e os serviços farmacêuticos. Para apresentar o perfil de renda dos entrevistados, os valores em BRL foram convertidos para USD utilizando a taxa de

câmbio fornecida pelo Banco Central do Brasil (2025), que era de USD 1 = BRL 5,87 (Rio de Janeiro, 2020b, Brasil, 2025).

Adicionalmente, foram avaliadas as experiências dos usuários no contexto farmacêutico, abrangendo todo o processo de aquisição e uso de medicamentos, incluindo medicamentos isentos de prescrição (MIPs) e medicamentos prescritos, desafios relacionados à polifarmácia e as percepções dos pacientes sobre o papel do farmacêutico no cuidado à saúde. As variáveis foram resumidas por meio de frequências absolutas e relativas, e as associações entre elas foram analisadas utilizando o teste qui-quadrado de Pearson. Os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando o valor de p foi <0,05. As análises foram conduzidas utilizando o Microsoft Excel 365 e o software R, versão 4.3.0.

Adicionalmente, avaliamos uma potencial associação entre o gênero, o nível de escolaridade, a cor da pele e a renda familiar dos participantes e suas percepções sobre o acesso e a qualidade dos serviços do SUS.

3.6. Aspectos éticos

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé (CAAE: 68864623.6.0000.5699). Todos os participantes assinaram o TCLE em duas vias antes da aplicação do questionário.

4. RESULTADOS

4.1. Características dos participantes

Com base na análise dos 1000 questionários, foi observado que a amostra era predominantemente feminina (66,2%), com uma faixa etária média de 25 a 45 anos (41,5%), e a maioria dos participantes tinha ensino médio completo (33,8%). A maioria dos participantes relatou utilizar os serviços do SUS (92,1%), conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1. Características dos participantes (n = 1000).

Variável	n	(%) *
Gênero		
Feminino	659	66,2%
Masculino	337	33,8%
Faixa etária (Anos de idade)		
18-25	166	16,6%
26 - 45	415	41,5%
46 - 60	255	25,5%
Mais de 60	163	16,3%
Raça/cor da pele		
Branco	385	39,4%
Negro	196	20,1%
Parda	390	40,0%
Outro	6	0,6%
Nível de educação		
Nunca estudou	15	1,5%
Ensino fundamental incompleto	141	14,5%
Ensino Fundamental completo	72	7,4%
Ensino médio incompleto	56	5,7%
Ensino Médio completo	390	40,0%
Ensino Superior Incompleto	145	15%
Ensino Superior completo	156	16,0%
Renda Familiar (Número de vezes o salário mínimo *)		
Até 1	161	18,4%
1 - 2	221	26,0%
2- 3	216	25,4%
3 - 5	264	19,3%
5 - 10	72	8,5%
10 - 20	14	1,6%
> 20	3	0,4%
Uso dos serviços do SUS Sim	927	93,6%
Tem plano de saúde particular sim	314	31,7%

Notas:* Gênero: 0,4% dos participantes não responderam a essas perguntas ("não sabe/não quer responder"); Raça/Cor da Pele: 2,3% dos participantes não responderam a essas perguntas ("não sabe/não quer responder"); Nível de escolaridade: 2,5% dos participantes não responderam a essas perguntas ("não sabe/não quer responder"); Renda familiar: 14,9% dos participantes não responderam a essas perguntas ("não sabe/não quer responder"); Salário mínimo em 2024: R$ 1412,00.

Alguns principais serviços foram identificados e apresentados na Figura 1 e na Figura 2 foram demonstradas as principais dificuldades para realização de serviços no SUS. Ressalta-se que para os tipos de serviços utilizados e as dificuldades enfrentadas, os entrevistados puderam relatar mais de uma opção no questionário.

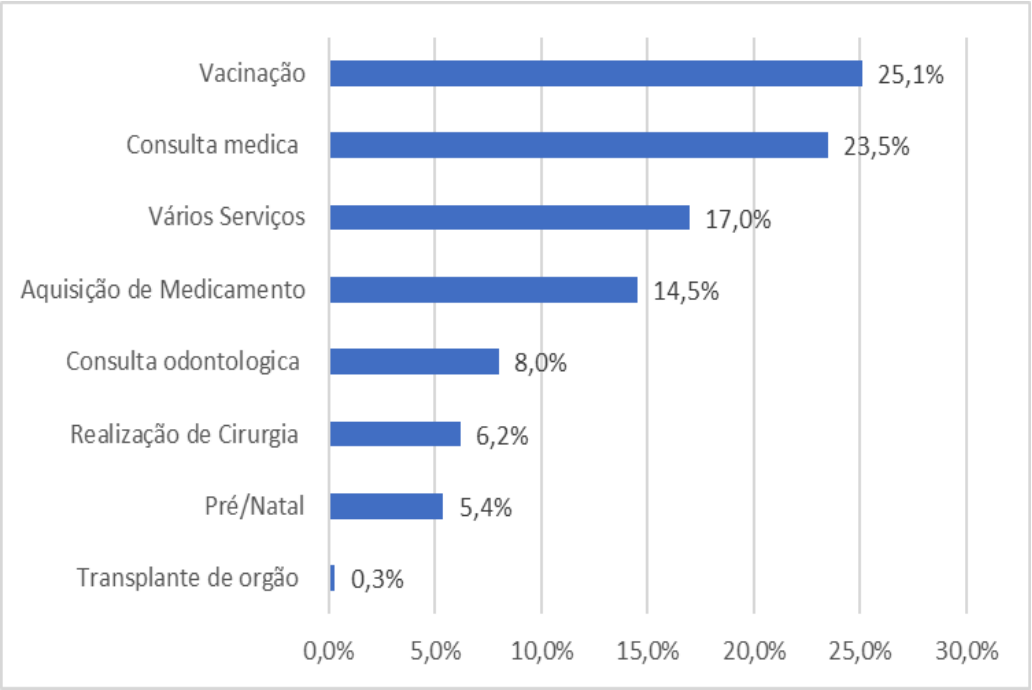

Figura 1 - ***Serviços mais utilizados no SUS relatados pelos participantes do estudo***

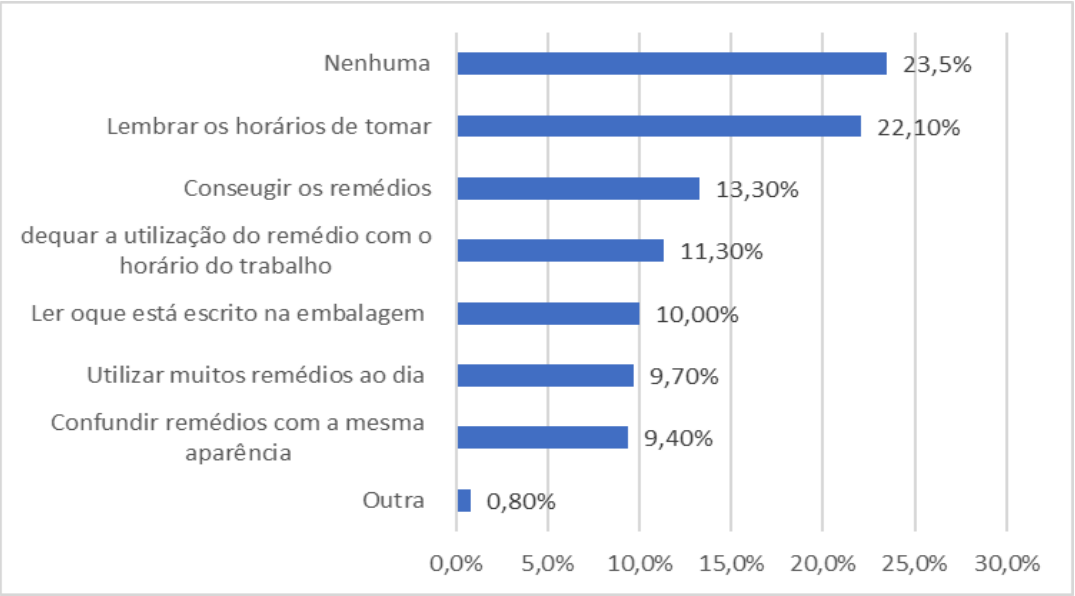

Figura 2 - ***Dificuldades relatadas pelos usuários ao tomar medicamento***

4.2. Avaliações e percepções dos usuários do SUS

990 (99%) da amostra relatou que atualmente usa ou já usou o SUS e, portanto, respondeu a perguntas relacionadas à segunda parte do questionário. Quando perguntados sobre consultas médicas, 47,4% afirmaram que dependem exclusivamente dos serviços do SUS, 33,3% usam tanto o SUS quanto planos de saúde privados, e 14,0% relataram usar apenas planos de saúde privados para consultas. Os 5,3% restantes dos entrevistados não responderam a essas perguntas (não sabem/não querem responder).

A maioria dos usuários do SUS o considera indispensável e essencial, sendo essa visão compartilhada tanto por aqueles que sempre usam o sistema (90,8%) quanto por aqueles que o usam raramente (82,1%). Entre aqueles que sempre usam o sistema, 40,6% classificou o acesso aos serviços do SUS como bom e 31,9% como nem bom nem ruim. Usuários ocasionais e não usuários classificaram o acesso como nem bom nem ruim (39,0% e 47,8%, respectivamente). Quando perguntados sobre a qualidade dos serviços, aqueles que sempre usam o sistema a descreveram como muito boa/boa, enquanto as avaliações mais negativas vieram daqueles que raramente ou nunca usam o sistema (24,2%), conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2. Percepções dos usuários do SUS sobre a relevância, acesso e qualidade dos serviços públicos de saúde (n = 990).

Relevância do SUS n (%)				
Frequência	**Indispensável**	**Complementar**	**Indiferente**	**p-valor**
Sempre	364 (90,8%)	29 (7,2%)	8 (2,0%)	
Frequentemente	112 (86,2%)	16 (12,3%)	2 (1,5%)	0,056
Às Vezes	219 (85,9%)	27 (10%)	9 (3,5%)	
Raramente	156 (82,1%)	24 (12,6%)	10 (5,3%)	
Todos	851 (87,2%)	96 (9,8%)	29 (3,0%)	

Acesso aos serviços do SUS n (%)						
Frequência	**Muito bom**	**bom**	**Nem Bom nem ruim**	**Ruim**	**Muito**	**p-valor**
Sempre	32 (8,2%)	159 (40,6%)	125 (31,9%)	54 (13,8%)	22 (5,6%)	
Frequentemente	6 (4,8%)	55 (44,0%)	43 (34,4%)	13 (10,4%)	8 (6,4%)	
Às vezes	10 (4,0%)	68 (27,3%)	97 (39,0%)	55 (22,1%)	19 (7,6%)	0,002
Raramente	10 (7,6%)	48 (36,4%)	38 (28,8%)	24 (18,2%)	12 (9,1%)	
Nunca	1 (2,2%)	10 (21,7%)	22 (47,8%)	8 (17,4%)	5 (10,9%)	
Todos	59 (6,3%)	340 (36,0%)	325 (34,4%)	154 (16,3%)	66 (7,0%)	

Qualidade do SUS n (%)				
Frequência	**Muito bom/bom**	**Nem bom nem ruim**	**Ruim/Muito ruim**	**p-valor**
Sempre	196 (48,6%)	135 (33,5%)	72 (17,9%)	
Frequentemente	66 (50,8%)	49 (37,7%)	15 (11,5%)	
Às vezes	92 (36,7%)	103 (41,0%)	56 (22,3%)	0,003
Raramente/ Nunca	65 (35,7%)	73 (40,1%)	44 (24,2%)	
Todos	419 (43,4%)	360 (37,3%)	187 (19,4%)	

Notas: *1,4% dos participantes não responderam a estas perguntas ("não sei/não quero responder");4,6% dos participantes não responderam a estas perguntas ("não sei/não quero responder"); 2,4% dos participantes não responderam a estas perguntas ("não sei/não quero responder")

Em relação às percepções de acesso, as regiões do Médio Paraíba e Metropolitana receberam as avaliações mais favoráveis, com 57,8% e 56,5% dos entrevistados classificando o acesso como muito bom/bom, respectivamente. Em contraste, o acesso foi classificado como o pior (ruim/muito, ruim) na região da Baixada Litorânea, com 36,3% dos usuários

relatando percepções negativas, conforme mostrado na Figura 3. Um padrão semelhante foi observado nas avaliações da qualidade do serviço: as regiões do Médio Paraíba e Metropolitana novamente apresentaram as respostas mais positivas (muito bom/bom) de 57,0% e 53,7% dos participantes, respectivamente, enquanto a região da Baixada Litorânea teve as avaliações mais negativas, com 30,9% classificando a qualidade como ruim/muito, ruim.

Não foi observada correlação estatisticamente significativa entre as percepções de acesso e qualidade dos serviços de saúde e fatores como gênero, renda familiar ou cor da pele (valor de $p > 0,05$). Adicionalmente, demonstramos na Figura 3 a percepção sobre o acesso aos serviços do SUS em cada região e qualidade dos serviços de saúde em cada região (n = 990).

Figura 3- (A) Percepção do acesso aos serviços do SUS em cada região. (B) Percepção da qualidade dos serviços de saúde em cada região. (n = 990). Notas: * 11,7% dos participantes não responderam a esta questão ("não sei/não quero responder"); 17,3% dos participantes não responderam a esta questão ("não sei/não quero responder").

Avaliações mais favoráveis do acesso e da qualidade dos serviços de saúde foram predominantemente relatadas por participantes com menor renda familiar, com uma associação significativa encontrada entre a renda familiar e as percepções de acesso aos

serviços do SUS (p = 0,001), conforme a Tabela 33. Entre os entrevistados que ganhavam menos que o salário mínimo, 56,0% classificou o acesso como "muito bom" ou "bom". Em relação à qualidade do serviço, 53,5% dos participantes nesse grupo de renda a classificaram como "muito boa" ou "boa", enquanto 45,8% daqueles que ganhavam mais de três salários mínimos a classificaram como "nem boa nem ruim".

Em relação à forma de obtenção de medicamentos, 47,6% dos participantes relataram adquiri-los exclusivamente em farmácias privadas, 40,5% obtiveram seus medicamentos em farmácias privadas e públicas, e apenas 9,7% relataram adquiri-los exclusivamente em farmácias públicas.

Quando questionados sobre o papel dos farmacêuticos, a maioria daqueles que obtinham medicamentos através do sistema público (exclusiva ou parcialmente) considerou o papel do farmacêutico essencial (82,7%), enquanto 12,3% o consideraram indiferente. Entre aqueles que adquiriram medicamentos apenas em farmácias privadas, 58,1% consideraram o farmacêutico essencial, enquanto 41,9% consideraram seu papel indiferente.

Tabela 3. Visões dos usuários do SUS [Sistema Único de Saúde] sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos de saúde associadas à renda familiar (n = 990).

Acesso ao serviço de Saúde n (%)				
Renda Familiar (Número de Vezes o Salário Mínimo)	**Muito Bom/Bom**	**Nem muito bom nem muito ruim**	**Ruim/Muito Ruim**	**p- valor**
Acima de 1	88 (56,0%)	35 (22,3%)	34 (21,7%)	
1 - 2	80 (37,7%)	76 (35,8%)	56 (26,4%)	
2 - 3	85 (42,1%)	70 (34,6%)	47 (23,3%)	
3 - 4	53 (34,2%)	62 (40,0%)	40 (25,8%)	
> 4	28 (33,3%)	39 (46,4%)	17 (20,3%)	
TOTAL*	334 (41,2%)	282 (34,8%)	194 (24,0%)	0,001
Qualidade do SUS n (%)				
Renda Familiar (Número de Vezes o Salário Mínimo))	**Muito Bom /Bom**	**Nem muito bom e nem muito ruim**	**Ruim/Muito Ruim**	**p- valor**
Acima de 1	85 (53,5%)	49 (30,8%)	25 (15,7%)	
1 - 2	90 (41,5%)	80 (36,9%)	47 (21,6%)	
2- 3	87 (41,0%)	84 (39,6%)	41 (19,3%)	0,164
3 - 4	62 (39,5%)	63 (40,1%)	32 (20,4%)	
> 4	29 (34,9%)	38 (45,8%)	16 (19,3%)	
Total	353 (42,6%)	35 (37,9%)	161 (19,5%)	

"Notas: * 81,8% dos participantes não responderam a estas perguntas (“não sei/não quero responder”); 55,5% dos participantes não responderam a estas perguntas (“não sei/não quero responder”)

Entre aqueles que adquiriram medicamentos apenas de farmácias públicas (n = 497), 26,8% relataram nunca ter recebido orientação sobre como usá-los, e 53,7% afirmaram nunca ter recebido instruções sobre como armazenar seus medicamentos. Além disso, 40,1% disseram que havia pelo menos um membro da equipe disponível na farmácia para responder a perguntas sobre medicamentos, enquanto 41,8% disseram nunca ter encontrado um farmacêutico em unidades de saúde públicas, conforme mostrado na Tabela 4.

Tabela 4. Visões dos usuários do SUS [Sistema Único de Saúde] sobre a aquisição de medicamentos em farmácias públicas (n = 497).

Questão	Respostas %					
	Sempre	*Frequentemente*	*Às vezes*	*Raramente*	*Nunca*	*Total*
Quando você pega medicamentos nas farmácias públicas do SUS, os funcionários que dispensam os medicamentos fornecem informação e/ou orientação sobre como usá-los?	146 (29,8%)	107 (21,9%)	67 (13,7%)	38 (7,8%)	131 (26,8%)	489 (100,0%)
Ao pegar medicamentos nas farmácias públicas do SUS, você recebe orientação sobre como armazená-los em casa?	68 (14,0%)	45 (9,2%)	64 (13,2%)	48 (9,9%)	261 (53,7%)	486 (100,0%)
O farmacêutico ou outro funcionário das farmácias públicas do SUS está disponível quando você precisa fazer perguntas sobre medicamentos?	170 (40,1%)	87 (20,5%)	82 (19,3%)	25 (5,9%)	60 (14,2%)	424 (100,0%)
Você já encontrou um farmacêutico na unidade pública que costuma frequentar (ESF, UBS ou unidade de dispensação de medicamentos)?	61 (15,7%)	76 (19,6%)	57 (14,7%)	32 (8,2%)	162 (41,8%)	388 (100,0%)

Notas:*1,6% dos participantes não responderam a esta pergunta (“não sei/não quero responder”);2,2% dos participantes não responderam a esta pergunta (“não sei/não quero responder”);14,7% dos participantes não responderam a esta pergunta (“não sei/não quero responder”);21,9% dos participantes não responderam a esta pergunta (“não sei/não quero responder”

5. DISCUSSÃO

Os serviços de saúde pública oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) desempenham um papel vital para a população brasileira, especialmente por meio da atenção primária, que serve como principal porta de entrada para o sistema de saúde. Este artigo mostrou que 93,3% da amostra relataram usar o SUS, sendo que aqueles que usou os serviços do SUS com mais frequência avaliou o acesso de forma mais positiva do que aqueles que usou menos (p-valor = 0,002). Participantes com menor nível socioeconômico também forneceram avaliações mais favoráveis sobre o acesso aos serviços de saúde pública (p = 0,001). Além disso, 25,1% dos entrevistados relataram usar o SUS para vacinação e 23,6% para consultas médicas, destacando seu papel no sistema de saúde.

Esses achados entram em ressonância com dados recentes de todo o Brasil (Vital Strategies *el al.*2025), que destacam a importância do SUS em atender grupos socialmente vulneráveis e as populações mais desfavorecidas. Isso ressalta a necessidade de políticas públicas que promovam a equidade e abordem as disparidades socioeconômicas e geográficas para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde pública. Uma alta renda familiar foi a principal característica observada no perfil da população que relatou não utilizar os serviços do SUS, representando 6,4% neste estudo, focado no estado do Rio de Janeiro, e 10,7% em uma amostra nacional (Uname,2025, Vital Strategies *el al.*2025).

Entre os usuários frequentes dos serviços do SUS, 90,8% o consideram indispensável, enquanto 82,1% daqueles que o utilizam raramente compartilham da mesma opinião. No entanto, quando questionados sobre o acesso, os usuários que relataram usar o SUS "sempre" ou "frequentemente" expressaram percepções mais favoráveis, com 40,6% e 44,6% avaliando-o como "bom", respectivamente. Esses achados se alinham com outros que mostraram que, apesar dos problemas reconhecidos nos serviços de saúde, os usuários frequentemente expressam satisfação com os serviços disponíveis (IBGE 2020, Cantalino *el al.,* 2021). Esse estudo entra de encontro com os da Inglaterra, que

Quando questionados sobre a qualidade dos serviços do SUS, 50,8% dos usuários frequentes avaliaram o sistema como “muito bom”, enquanto 44% deram uma avaliação neutra (“nem bom nem ruim”). Em contraste, entre aqueles que raramente utilizam os serviços de saúde pública, 24,2% os classificaram como “ruins”. Esses resultados sugerem que aqueles que usam os serviços do SUS tendem a ter uma percepção mais positiva em comparação com aqueles que o utilizam com menos frequência, e que podem, em vez disso, depender de plano

de saúde privada. Resultados semelhantes foram observados em 2019 (IBGE 2020). Isso é parecido com os achados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, onde 60,6% dos usuários hospitalizados avaliaram o atendimento que receberam como bom (São Paulo, 2023). No entanto, 74% dos entrevistados afirmaram ter enfrentado algum tipo de barreira ao acessar os serviços de saúde. Um estudo da Inglaterra mostra que recentemente, apesar da avaliação do sistema de saúde tenha caído entre os mais pobres, a percepção sobre o acesso e sua qualidade de saúde continua boa para maioria da população, que a utiliza (MORRIS, 2023).

Em 2018, 39% dos pacientes com doenças crônicas obtinham seus medicamentos em farmácias públicas, sendo que a maioria das pessoas obtinha seus medicamentos em farmácias privadas (incluindo programas de farmácia popular) ou através de uma combinação de fontes públicas e privadas (Matta *el al.,* 2018). Este estudo descobriu que apenas 9,7% dos entrevistados relataram adquirir medicamentos em unidades públicas. Essa disparidade pode ser atribuída a variações regionais, indicando um acesso abaixo do nível a medicamentos em unidades públicas dentro do estado do Rio de Janeiro. Além disso, dado que o programa Farmácia Popular é administrado por meio de farmácias privadas (Oliveira *el al.,* 2016), os entrevistados podem ter relatado a obtenção de medicamentos em farmácias privadas, mesmo que estes tivessem sido adquiridos por meio desta iniciativa de política pública. Iremos acompanhar isso em estudos futuros.

Entre os participantes que obtiveram medicamentos em farmácias públicas neste estudo, a maioria (82,7%) reconheceu o papel dos farmacêuticos como essencial, embora o papel mais amplo das farmácias seja frequentemente subestimado pelo público (Peixoto *el al*. 2022). Quando questionados sobre o recebimento de orientações ao obter medicamentos, 26,85% dos entrevistados afirmaram que nunca haviam recebido tal orientação, e 53% relataram nunca ter recebido informações sobre como armazenar medicamentos ou as precauções necessárias. Além disso, 48,1% nunca haviam visto um farmacêutico prestando orientação em uma UBS (Unidade Básica de Saúde), Estratégia Saúde da Família (ESF) ou local de dispensação. Um estudo conduzido durante a pandemia mostrou que, embora 95% das pessoas percebam o farmacêutico como um profissional de saúde, 68,6% não buscaram orientação deles, e 53,4% nunca haviam visto um (Lacerda Sampaio; Dourado, 2021). Isso indica uma aparente desconexão entre o papel percebido do farmacêutico e a plena utilização dos seus serviços. A falta de presença do farmacêutico na UBS e na ESF contribui para essa situação, com apenas 15% das UBS contando com um farmacêutico. Nas unidades que possuem esses profissionais, há melhor distribuição de medicamentos e maior disponibilidade

(Lacerda Sampaio; Dourado, 2021). Esses achados fornecem orientação para as farmácias comunitárias no futuro, para ajudar a melhorar o uso de medicamentos no país e ressaltam a importância do investimento contínuo neste setor de saúde crucial (Marinho *el al.,* 2025).

Enquanto 93,3% dos participantes relataram usar o SUS, 31,7% relataram ter planos de saúde privados, acima da média nacional de 25%, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (Agência Nacional de Saúde Suplementar 2025). O percentual mais alto de participantes que possuem plano de saúde privado, em comparação com o esperado no país, pode estar associado a um melhor status socioeconômico e/ou perfil de emprego formal em nossa amostra. Muitos brasileiros possuem planos de saúde privados, com base em facilidades e/ou benefícios envolvendo suas respectivas empresas (por exemplo, multinacionais, empresas estatais e setor de serviços). A concentração de renda e as oportunidades de emprego são alguns dos incentivos pelos quais os indivíduos buscam a cobertura de saúde privada para suas famílias (Souza Júnior *el al.,* 2021). Notavelmente, as regiões das Baixadas Litorâneas e do Norte Fluminense relataram a maior dependência do SUS. Isso se deve não apenas a fatores socioeconômicos, mas também porque o acesso e a qualidade dos serviços de saúde pública frequentemente influenciam se os usuários recorrem a serviços privados (Mahmood *el al.,* 2024).

As cinco regiões do estado do Rio de Janeiro revelaram percepções variadas sobre o sistema de saúde. A Baixada Litorânea avaliou o acesso e a qualidade de forma mais negativa em comparação com a região Metropolitana, que demonstrou avaliações mais favoráveis. Isso também foi observado na região Norte Fluminense, onde uma parcela maior da população utiliza planos de saúde privados, enquanto a região Metropolitana depende mais do sistema público. Além disso, algumas regiões, incluindo as Baixadas Litorâneas e a Serrana, enfrentam escassez de serviços de UBS (Unidades Básicas de Saúde) e ESF (Estratégia Saúde da Família). Um estudo relacionado, conduzido dentro deste mesmo projeto de pesquisa, na região das Baixadas Litorâneas (Souza *el al.,* 2024), demonstrou que a falta de unidades de Atenção Primária à Saúde, bem como a ausência de farmacêuticos em instalações como as UBS, impactou negativamente a percepção da população sobre o acesso e a qualidade dos serviços de saúde. Além dos achados deste estudo e de outros conduzidos pelo mesmo grupo de pesquisa, é importante notar que, embora as percepções dos usuários sejam um tanto positivas, a opinião pública pode ser significativamente influenciada pela mídia digital (Santos *el al.,*2022). Neste contexto, aspectos negativos como atrasos no atendimento e erros

médicos recebem maior visibilidade, enquanto os pontos fortes e as conquistas do sistema são frequentemente minimizados ou negligenciados (Santos *el al.,*2022). Como resultado, o SUS tornou-se alvo de ataques políticos e sociais que ameaçam sua estrutura e colocam em risco a continuidade de um dos programas mais importantes da história do país, representando um retrocesso diante dos progressos já alcançados na saúde pública (Santos *el al.,*2022). Consequentemente, é essencial compreender as demandas sociais e, sobretudo, desenvolver estratégias que garantam que o SUS seja responsivo às necessidades da população e receba amplo apoio social.

Entre os nossos resultados, observamos que 10,5% dos participantes tinham uma renda familiar de mais ou menos cinco salários mínimos, 60% se autodeclararam Pretos ou Pardos, e apenas 16,3% eram idosos (>60 anos), de acordo com a classificação brasileira (Brasil 200). Dados do último censo demográfico do Rio de Janeiro indicam que o percentual combinado da população Preta e Parda foi superior ao de outros grupos em todas as regiões do estado (IBGE,2022; Rio de Janeiro, 2024), com uma maior proporção de mulheres e um menor percentual de indivíduos acima de 60 anos (IBGE,2022; Rio de Janeiro, 2024), características também observadas em nosso estudo. Alguns estudos publicados, embora não tenham incluído análises estatísticas correlacionando as percepções dos entrevistados sobre os serviços do SUS com características socioeconômicas (ou seja, renda e escolaridade), geralmente observaram uma predominância de participantes que se autodeclararam Pretos e/ou Pardos, juntamente com um menor percentual de indivíduos com ensino superior e/ou renda mais alta (Cantalino *el al*, 2021; IBGE,2022; Novais Martins, 2010), o que é um perfil demográfico semelhante ao do nosso estudo.

Reconhecemos que este estudo apresenta algumas limitações, incluindo o uso de amostragem não probabilística por conveniência. Essa estratégia foi adotada devido à impossibilidade de realizar amostragem probabilística em uma população-alvo grande e heterogênea, composta por centenas de milhares de usuários do SUS. Dada a ausência de um registro unificado e acessível desses usuários para fins de seleção aleatória, o questionário foi aplicado a participantes que estavam dentro ou próximos a serviços de saúde no momento da coleta de dados. Embora essa abordagem limite a generalização estatística dos achados para toda a população de usuários do SUS, ela é frequentemente empregada em pesquisas aplicadas na área da saúde (Althubaiti, 2022; Ahmad, 2024), particularmente ao investigar percepções e experiências subjetivas, como na avaliação do acesso e da qualidade dos

serviços de saúde (Hulley *el al.,* 2013; Gil, 2019). Além disso, foram aplicados critérios rigorosos de inclusão e exclusão, e esforços foram feitos para garantir a diversidade nos perfis sociodemográficos dos participantes, o que acreditamos contribuir para a validade interna do estudo. Adicionalmente, considerando que o estudo envolveu estudantes de graduação de uma universidade pública no Brasil e que o projeto não possuía financiamento disponível, os municípios e regiões do estado do Rio de Janeiro selecionados para participação foram aqueles com maior acessibilidade e viabilidade em termos de transporte, acomodação e alimentação, permitindo que as entrevistas fossem conduzidas por uma equipe de entrevistadores voluntários. Devido a desafios logísticos, não foi possível incluir todos os municípios ou algumas localidades que poderiam ter aprimorado a representação regional, como no caso da região Serrana, que representa aproximadamente 21% da população. Não obstante, priorizamos áreas com maior relevância socioeconômica, visando fomentar reflexões significativas sobre o tema no contexto estadual. Além disso, por ser um estudo descritivo, ele possui certas limitações, como o foco na descrição dos achados em vez de testar hipóteses ou explicar mecanismos, o que limita o potencial de generalização (Aggarwal; Ranganathan, 2019). Contudo, considerando a escassez de publicações sobre os temas abordados, aliada ao número apreciável de participantes neste estudo, acreditamos que nossos achados contribuirão para futuras discussões sobre os desafios regionais na promoção dos serviços de saúde pública em um sistema universal.

No geral, acreditamos que nosso estudo oferece valiosas contribuições para o planejamento e desenvolvimento de iniciativas de saúde pública, particularmente no contexto de um dos estados mais importantes do Brasil, bem como para outras regiões no Brasil que enfrentam desafios semelhantes. Esforços e iniciativas de pesquisa, como projetos ou estratégias que promovam o diálogo e o "escuta ativa" dos usuários do SUS, são essenciais para a tomada de decisões informadas pelos gestores de saúde. Esses insights sobre as experiências dos usuários podem ajudar a guiar a implementação e o aprimoramento dos serviços para melhor atender às necessidades da população. Os resultados também podem ser de interesse para outros países que enfrentam desafios socioeconômicos e compartilham o objetivo de expandir o acesso a serviços de saúde de qualidade para suas populações.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa mostrou que a população do estado do Rio de Janeiro percebe o SUS como um serviço público essencial, e o acesso e a qualidade dos serviços são avaliados de forma positiva, especialmente por seus usuários mais frequentes. Também revelou disparidades regionais significativas dentro do estado, particularmente em relação aos serviços prestados pela Atenção Primária e aos serviços farmacêuticos. Promover pesquisas e estratégias que incentivem o diálogo contínuo e construtivo entre a população e os tomadores de decisão é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e adaptadas às necessidades locais. Para manter a qualidade da prestação de serviços de saúde, é necessário um diálogo contínuo e construtivo entre a população e os tomadores de decisão, enfatizando a importância do engajamento local para garantir tanto o acesso quanto a qualidade dos serviços entregues pelos municípios no contexto federativo brasileiro.

Este estudo abrangeu cinco das sete regiões de um dos maiores estados do Brasil. Apesar de estar localizado no Sudeste, uma região com condições socioeconômicas mais favoráveis em comparação com o Norte e o Nordeste, as percepções dos usuários indicam que muitas dificuldades e desafios persistem, como a oferta de cuidados especializados, especialmente em áreas do interior, como a região das Baixadas Litorâneas. Esses achados refletem os desafios reais enfrentados pelos usuários e têm implicações para a gestão pública, para que princípios como a universalidade e a integralidade possam ser efetivamente alcançados em contextos práticos.

Os resultados insatisfatórios do acesso a medicamentos em unidades públicas do estado do Rio de Janeiro em comparação com pesquisas nacionais exigem que mais pesquisas sejam realizadas para investigar isso mais a fundo. Por fim, a necessidade da presença de farmacêuticos em farmácias comunitárias, UBS e ESF foi destacada, dada a sua capacidade de influenciar positivamente os indicadores de saúde e a qualidade de vida dos usuários, em alinhamento com os princípios constitucionais nos quais o SUS foi fundado.

7. REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 20 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 9 ago. 2025.

2. BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 31 dez. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 9 ago. 2025.

3. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). *OECD Reviews of Health Systems: Brazil 2021*. Paris, France: OECD Publishing, 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/publications/oecd-reviews-of-health-systems-brazil-2021-a4b3b4d3-en.htm. Acesso em: 5 ago. 2025.

4. PHYSIS. Regionalização em Saúde no Brasil: Uma Análise da Percepção dos Gestores de Comissões Intergestores Regionais. *Physis Rev. Saúde Coletiva*, v. 32, p. 1–23, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-73312022320105.

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. *Estabelece Diretrizes Para a Organização da Rede de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)*. Brasília, Brazil: Diário Oficial da União, Ministério da Saúde, 2010.

6. ELIDIO, G. A. *el al*. Atenção primária à saúde: A maior aliada na resposta à epidemia da dengue no Brasil. *Rev. Panam. Salud Publica*, v. 48, e47, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.26633/RPSP.2024.47.

7. BOUSQUAT, A. *el al*. Pandemia de covid-19: O SUS mais necessário do que nunca. *Revista USP*, v. 1, p. 13–26, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.i128p13-26.

8. BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção Básica*. Brasília, Brazil: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2017.pdf. Acesso em: 17 jun. 2025.

9. BRASIL. Ministério da Saúde. *Estratégia e-Multi: Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde*. Brasília, Brazil: Ministério da Saúde, 2022.

10. PEIXOTO, R. T. *el al*. O farmacêutico na Atenção Primária à Saúde no Brasil: Análise comparativa 2014-2017. *Saúde Debate*, v. 46, p. 358–375, 2022. Disponível em: https://revista.saudeemdebate.org.br/sed/article/view/6410. Acesso em: 17 jun. 2025.

11. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. *ANS Divulga Dados de Beneficiários Referentes a Agosto de 2024*. Brasília, Brazil, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/ans-divulga-dados-de-beneficiarios-referentes-a-agosto-de-2024. Acesso em: 10 out. 2024.

12. SOUZA JÚNIOR, P. R. B. *el al*. Cobertura de plano de saúde no Brasil: Análise dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013 e 2019. *Ciência Saúde Coletiva*, v. 26, p. 2529–2541, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.1.43532020.

13. INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE. *Estado do Rio Tem a pior Cobertura de Atenção Básica do SUS no país; Piauí, a melhor: Veja o ranking*. [S.l.: S.n.], 2025. Disponível em: https://ieps.org.br/estado-do-rio-tem-a-pior-cobertura-de-atencao-basica-do-sus-no-pais-piaui-a-melhor-veja-o-ranking/. Acesso em: 15 jan. 2025.

14. ECONOMIST IMPACT. *The Road to Health Inclusivity: From Policy to Practice*. 2023. Disponível em: https://impact.economist.com/projects/health-inclusivity-index/documents/the_road_to_health_inclusivity_health_inclusivity_index_2023_economist_impact_final.pdf. Acesso em: 9 ago. 2025.

15. DORNAS, B. S. S. *el al*. Percepções sobre os serviços de saúde pública em macaé-rj: Um estudo transversal. *Rev. Saúde Pública Paraná*, v. 7, p. 1–20, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.32811/25954482-2024v7n4.983.

16. SOUZA, J. S. *el al*. Users' perceptions of access to and quality of unified health system services in brazil: A cross-sectional study and implications to healthcare management challenges. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, v. 21, 721, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijerph21060721.

17. RAIMUNDO, M. C. *el al*. Users' perceptions of access to and quality of public health services in brazil: A cross-sectional study in metropolitan rio de janeiro, including pharmaceutical services. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, v. 22, 967, 2025.

18. PICORELLI, L. F. O papel da participação comunitária no SUS. *Rev. Direito Med.*, v. 1, p. 1–20, 2019. Disponível em: https://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2022/06/01/13_19_11_463_O_papel_da_participa_o _comunit_ria_no_SUS.pdf. Acesso em: 17 jan. 2025.

19. CARING FOR CANADIANS: Canada's Future Health Workforce – The Canadian Health Workforce Education, Training and Distribution Study, 2025. Disponível em: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/health-human-resources/workforce-education-training-distribution-study.html. Acesso em: 6 ago. 2025.

20. HS ENGLAND. *Working in Partnership with People and Communities: Statutory Guidance*. London: NHS England, 2023. Disponível em: https://www.england.nhs.uk/long-read/working-in-partnership-with-people-and-communities-statutory-guidance/. Acesso em: 6 ago. 2025.

21. VITAL STRATEGIES *el al*. *More Data Better Health: Acesso e Percepção da População Brasileira Sobre a Atenção Primária à Saúde, Módulo 1*. São Paulo, Brazil, 2025. Disponível em: https://www.vitalstrategies.org. Acesso em: 6 ago. 2025.

22. GADELHA, C. A. *el al*. PNAUM: Integrated approach to pharmaceutical services, science, technology and innovation. *Rev. Saude Publica*, v. 50, n. Suppl. 2, 3s, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2016050006153.

23. FARDOUSI, N. *el al*. Performance bonuses and the quality of primary health care delivered by family health teams in brazil: A difference-in-differences analysis. *PLoS Med.*, v. 19, e1004033, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004033.

24. MENGUE, S. S. *el al*. National survey on access, use and promotion of rational use of medicines (PNAUM): Household survey component methods. *Rev. Saude Publica*, v. 50, n. Suppl. 2, 4s, 2016.

25. MELLO, L. A. F. *el al*. Evaluation of primary health care units in the Rio de Janeiro city according to results of pmaq 2012. *J. Ambul. Care Manag.*, v. 40, S71–S82, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1097/JAC.0000000000000188.

26. PROTASIO, A. P. L. *el al*. User satisfaction with primary health care by region in Brazil: 1st cycle of external evaluation from PMAQ-AB. Satisfação do usuário da Atenção

Básica em Saúde por regiões do Brasil: 1º ciclo de avaliação externa do PMAQ-AB. *Ciência Saúde Coletiva*, v. 22, p. 1829–1844, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232017226.26472015.

27. PROTASIO, A. P. *el al*. Factors associated with user satisfaction regarding treatment offered in Brazilian primary health care. *Cad. Saúde Publica*, v. 33, e00184715, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00184715.

28. MEDEIROS, T. M. *el al*. Desafios da universalidade no SUS: Avaliação do acesso e qualidade dos serviços de saúde no brasil. *Cad. Pedag.*, v. 21, e5102, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.54033/cadpedv21n6-212.

29. UMANE. *Estudo Inédito Revela Percepção Sobre Acesso e Qualidade da Atenção Primária à Saúde*. Disponível em: https://biblioteca.observatoriosaudepublica.com.br/blog/saude-publica-no-brasil-atencao-primaria/. Acesso em: 9 ago. 2025.

30. VITAL STRATEGIES *el al*. *Mais Dados Mais saúde–Atenção Primária à Saúde*. Brasil, 2025. ISBN 978-65-85591-09-6. Disponível em: https://pesquisa.atlasintel.org. Acesso em: 8 ago. 2025.

31. CAMPOS, D. S. Saúde e políticas sociais no rio de janeiro brasil: História, caminhos e tendências. *Cad. Saúde Pública*, v. 35, e00065119, 2019.

32. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico brasileiro de 2022. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/. Acesso em: 15 ago. 2024.

33. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Diagnóstico de saúde da região metropolitana I. Secretaria de Saúde, Rio de Janeiro, 2020.

34. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Diagnóstico de saúde da região metropolitana II. Secretaria de Saúde, Rio de Janeiro, 2020.

35. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Diagnóstico de saúde da região norte. Secretaria de Saúde, Rio de Janeiro, 2020.

36. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Diagnóstico de saúde da região baixada litorânea. Secretaria de Saúde, Rio de Janeiro, 2020.

37. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Diagnóstico de saúde da região médio paraíba. Secretaria de Saúde, Rio de Janeiro, 2020.

38. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Diagnóstico de saúde da região serrana. Secretaria de Saúde, Rio de Janeiro, 2020.

39. ALTHUBAITI, A. Sample size determination: a practical guide for health researchers. *Journal of General and Family Medicine*, v. 24, p. 72–78, 2022. DOI: 10.1002/jgf2.600.

40. BRASIL. Banco Central do Brasil. Histórico de cotação. Brasília, 2025. Disponívelem: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes. Acesso em: 15 abr. 2025.

41. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa nacional de saúde 2019: informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101748.pdf. Acesso em: 10 maio 2025.

42. CANTALINO, J. L. R.; SCHERER, M. D. D. A.; SORATTO, J.; SCHÄFER, A. A.; ANJOS, D. S. O. D. Satisfação dos usuários em relação aos serviços de Atenção Primária à Saúde no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 55, p. 22, 2021. Disponível em: https://revistas.usp.br/rsp/article/view/186498. Acesso em: 17 jun. 2025.

43. SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Saúde. Pesquisa de satisfação dos usuários do SUS/SP. São Paulo, 2023. Disponível em: https://fedap.com.br/2023/09/12/governo-de-sp-lanca-pesquisa-de-satisfacao-dos-usuarios-do- sus-paulista/. Acesso em: 10 maio 2025.

44. MORRIS, J. **Public Satisfaction With The NHS And Social Care In 2022**. Disponível em: <https://www.kingsfund.org.uk/insight-and-analysis/reports/public-satisfaction-nhs-and-social -care-2022>.

45. MATTA, S. R.; BERTOLDI, A. D.; EMMERICK, I. C. M.; FONTANELLA, A. T.; COSTA, K. S.; LUIZA, V. L. Fontes de obtenção de medicamentos por pacientes diagnosticados com doenças crônicas, usuários do Sistema Único de Saúde. Cadernos de Saúde Pública, v. 34, e00073817, 2018. DOI: 10.1590/0102-311x00073817.

46. OLIVEIRA, M. A. *el al*. Access to medicines for chronic diseases in Brazil: a multidimensional approach. Revista de Saúde Pública, v. 50, supl. 2, p. 6s, 2016. DOI: 10.1590/S1518-8787.2016050006161.

47. LACERDA, M. G. C.; SAMPAIO, J. P. S.; DOURADO, C. S. M. E. Percepção da população sobre o papel do farmacêutico no contexto da pandemia do novo coronavírus.

Research, Society and Development, v. 10, e54310918304, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i9.18304.

48. MARINHO, L. N. *el al*. Public health financing in Brazil (2019–2022): an analysis of the National Health Fund and implications for health management. Frontiers in Public Health, v. 13, 1568351, 2025. DOI: 10.3389/fpubh.2025.1568351.

49. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Dados econômico-financeiros do setor de planos de saúde: 1º trimestre de 2025. Brasília, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/ans. Acesso em: 10 maio 2025.

50. MAHMOOD, S. *el al*. Decentralization of the health system: experiences from Pakistan, Portugal and Brazil. Health Research Policy and Systems, v. 22, p. 61, 2024. DOI: 10.1186/s12961-024-01145-3.

51. SANTOS, R. T. *el al*. Saúde pública e comunicação: impasses do SUS à luz da formação democrática da opinião pública. Ciência & Saúde Coletiva, v. 27, p. 1547–1556, 2022. DOI: 10.1590/1413-81232022274.02622021.

52. BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1 out. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 31 ago. 2025.

53. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. População residente: estudo de estimativas populacionais por município, idade e sexo 2000–2024, pactuada pela SES-RJ. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnetbd/dhx.exe?populacao/pop_populacao_ripsa2024.def. Acesso em: 10 maio 2025.

54. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa nacional de saúde 2019: atenção primária à saúde e informações antropométricas. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://www.pns.icict.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/02/liv101758.pdf. Acesso em: 31 ago. 2025.

55. NOVAIS, M.; MARTINS, C. B. Perfil dos beneficiários de planos e SUS e o acesso a serviços de saúde – PNAD 2003 e 2008. Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), 2010. Disponível em: https://www.iess.org.br/sites/default/files/2021-04/TD35.pdf. Acesso em: 31 ago. 2025.

56. AHMED, S. K. Research methodology simplified: how to choose the right sampling technique and determine the appropriate sample size for research. Oral Oncology Reports, v. 12, 100662, 2024. DOI: 10.1016/j.oor.2024.100662.

57. HULLEY, S. B. *el al*. *Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica.* 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

58. GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social.* 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

59. AGGARWAL, R.; RANGANATHAN, P. Study designs: part 2 – descriptive studies. *Perspectives in Clinical Research*, v. 10, p. 34–36, 2019. DOI: 10.4103/picr.PICR_154_18.

8. APÊNDICE

International Journal of
Environmental Research and Public Health

MDPI

Article

Users' Perspectives on Primary Care and Public Health Services in the State of Rio de Janeiro, Brazil: A Cross-Sectional Study with Implications for Healthcare Quality Assessment

Igor F. L. Ferraz [1], Mariana C. Raimundo [1], Natalia M. A. M. Barros [1], Jhoyce S. Souza [1], Barbará M. V. Lucio [1], Thiago P. Tenreiro [1], Edna A. Reis [2,3], Danielle Maria de Souza Serio dos Santos [1,3], Luisa A. Chaves [1,3], Brian Godman [4,5,6], Stephen M. Campbell [5,7], Johanna C. Meyer [5,8] and Isabella Piassi D. Godói [1,3,*]

[1] Institute of Pharmaceutical Sciences, Federal University of Rio de Janeiro, Avenida Aluízio da Silva Gomes 50—Granja dos Cavaleiros, Macaé 27930-560, RJ, Brazil; igorfradique@gmail.com (I.F.L.F.); maricrespo.r2@gmail.com (M.C.R.); natmmbarros@gmail.com (N.M.A.M.B.); jhoyce.tcc.ufrj@gmail.com (J.S.S.); bah_mvl@hotmail.com (B.M.V.L.); thiagopereira900@gmail.com (T.P.T.); dani.farma84@gmail.com (D.M.d.S.S.d.S.); luisa.arueira@gmail.com (L.A.C.)

[2] Department of Statistics, Exact Sciences Institute, Federal University of Minas Gerais, Campus Pampulha, Avenida Antônio Carlos 6627, Belo Horizonte 31270-901, MG, Brazil; ednareis@gmail.com

[3] Health Technology Assessment Center—Management, Economics, Health Education and Pharmaceutical Services (GEESFAR/NATS/UFRJ) of the Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 27930-560, RJ, Brazil

[4] Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Strathclyde, Glasgow G1 1XQ, UK; brian.godman@strath.ac.uk

[5] Department of Public Health Pharmacy and Management, School of Pharmacy, Sefako Makgatho Health Sciences University, Ga-Rankuwa, Pretoria 0208, South Africa; stephen.campbell@manchester.ac.uk (S.M.C.); hannelie.meyer@smu.ac.za (J.C.M.)

[6] Antibiotic Policy Group, Institute for Infection and Immunity, City St. George's, University of London, London SW17 0RE, UK

[7] School of Health Sciences, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK

[8] South African Vaccination and Immunisation Centre, Sefako Makgatho Health Sciences University, Ga-Rankuwa, Pretoria 0208, South Africa

* Correspondence: isabellapiassi@gmail.com

check for updates

Academic Editors: Nick Garrett and George Crooks

Received: 4 July 2025
Revised: 3 September 2025
Accepted: 9 September 2025
Published: 12 September 2025

Citation: Ferraz, I.F.L.; Raimundo, M.C.; Barros, N.M.A.M.; Souza, J.S.; Lucio, B.M.V.; Tenreiro, T.P.; Reis, E.A.; de Souza Serio dos Santos, D.M.; Chaves, L.A.; Godman, B.; *el al*. Users' Perspectives on Primary Care and Public Health Services in the State of Rio de Janeiro, Brazil: A Cross-Sectional Study with Implications for Healthcare Quality Assessment. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2025**, *22*, 1424. https://doi.org/10.3390/ ijerph22091424

Copyright: © 2025 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

This study focuses on the Unified Health System (SUS) in five regions of the state of Rio de Janeiro, Brazil, one of Brazil's most important states, as part of a comprehensive analysis of a research project, which has generated publications in earlier phases. The objective was to assess users' perceptions of SUS in terms of access to and the quality of public health services, including primary care and pharmaceutical services. A cross-sectional study was conducted using a structured questionnaire comprising 66 questions, administered to a purposive sample of 1000 participants between August 2023 and August 2024. Data were analyzed using Pearson's chi-square test with R software version 4.3. Among the participants, 54.5% were female, 62.5% were aged between 26 and 60 years, and

29% reported having private health insurance. Vaccination services were the most frequently used SUS service (25.1% of respondents). Participants who reported more frequent use of SUS services rated access more positively than those who used them less frequently (p = 0.002). The regions that evaluated SUS access and quality most favorably were Middle Paraíba and the metropolitan region, while the Coastal Lowlands region received the most negative assessments. Participants with lower socioeconomic status gave more favorable evaluations of access to public health services (p = 0.001). These findings highlight concerns about access to, and the quality of, SUS healthcare services and regional disparities in users' perceptions of SUS services in Rio de Janeiro. The results underscore the importance of social participation as a key element in the evaluation and continuous improvement of responsive public healthcare.

Keywords: Brazil; access; quality; health services; users; public health; healthcare quality assessments

1. Introduction

The 1988 Constitution marked a milestone for public health in Brazil, with Article 196 establishing health as a right for all citizens in Brazil and a duty of the State [1]. Follow- ing the institutionalization of the Unified Health System (SUS) in 1990, key principles were defined for the healthcare system. Key principles included universality, comprehensiveness, hierarchical organization, and social participation [2]. Alongside this, foundational guidelines were introduced to improve the diverse range of potential health actions [1,2]. Overall, SUS represents a significant social achievement and a substantial transformation in Brazil's health landscape to improve the population's well-being [1–3]. Managing this universal system involves financial, logistical, and human resources across different autonomous political and administrative entities (federal, state, and municipal). In this arrangement, the municipalities are responsible for providing the majority of health services [1,2]. This decentralization strategy necessitates collaboration and cooperation to align health services with local needs [4].

SUS is organized into different levels of care to enhance the rational use of available resources, which range from Primary Health Care (PHC) and Secondary Care to highly complex and specialized services in Tertiary Care facilities [5]. Within this structure, PHC plays a central role in promoting health and preventing diseases, reducing morbidity and mortality, and serving as the main entry point to health care as well as being the gatekeeper to more complex services when necessary [6]. One of the most socially recognized initiatives under SUS is the National Immunization Program (PNI). Since its inception in 1973, PNI has achieved several milestones, including the eradication of smallpox and the containment of epidemics, including COVID-19 [7].

In Brazil, the composition of primary care teams follows the guidelines of the National Primary Care Policy (PNAB). However, municipalities have the autonomy to structure their teams based on local needs, provided they meet the established minimum standards for PHC [8]. The Family Health Strategy (ESF) is the standard model, with teams comprising family physicians, nurses, community health agents (CHAs), and nursing technicians. It is also recommended that the municipalities include an Oral Health Team (ESB), primarily consisting of dentists and technicians, as well as Multidisciplinary Teams (EMulti), which include professionals such as nutritionists, physiotherapists, psychologists, and social workers [9]. Whilst the presence of a pharmacist is not mandatory in EMulti, their role is crucial in pharmaceutical services to improve the dispensing and management of medicines' use, which directly benefits families served by PHC [10].

Whilst SUS is founded on the principle of universal and comprehensive access to services for the entire population, approximately 25% of the population has a private health insurance plan [11]. Whilst many health insurance beneficiaries have their coverage paid by their employers and not through direct payments [12], one of the main motivations for acquiring private coverage is the perceived greater ease in scheduling appointments with specialists [13]. A key reason is the current obstacles encountered in accessing SUS services, aggravated by increasing demand [14]. There can also be concerns with unequal access of funds across the different regions of Brazil to meet unmet needs, which again impacts the availability of comprehensive healthcare services [15–17].

Social participation is a cornerstone in ensuring that the population's needs and demands are responded to, reflecting the foundational principles of the SUS [18]. In Brazil,

Law No. 8142/1990 establishes social participation as one of the pillars of this universal system, highlighting the value of citizen engagement through mechanisms such as Health Councils and Health Conferences in shaping and strengthening the SUS [2,17]. Other countries with public health systems, including Canada [19] and the United Kingdom [20], also incorporate social participation as a key principle. The importance of public opinion in improving health systems informs SUS planning [21], underscoring the relevance of studies that explore users' perspectives to inform future decision-making.

To collect data and foster discussions on the evaluation of various types of public health services in Brazil, the federal government developed programs such as the 2013 National Survey on the Rational Use of Medicines in Brazil (PNAUM), which aimed to evaluate, at a national level, the use and promotion of the rational use of medicines [22]. Alongside this is the 2011 Program for the Improvement of Access and Quality of Pri- mary Care (PMAQ), which assessed the performance of health teams and the quality of services offered in primary care, aiming at the continuous improvement of care pro- vided to the population [23]. These earlier programs contributed to surveys focusing on medication use, e.g., medication use by age group, difficulties encountered, and other findings in the country [22–27], as well as reflections on the provision of public health ser- vices [22–27]. These programs employed questionnaires as data collection tools, which sub- sequently served as references for the development of further research studies addressing these topics [15–17].

After the discontinuation of the aforementioned programs between 2015 and 2019, few publications [28–30] and/or studies on this topic in Brazil have been published. A systematic review was published in 2024 that focused on the challenges of universality in the SUS and evaluated access to and quality of health services in Brazil, including eight studies conducted before 2020 [28]. Additionally, a survey was published in April 2025, based on a digital questionnaire with a 4.7% response rate that included 2458 participants from various regions of the country, evaluating access to and quality of Primary Health Care. These studies showed that users who most frequently utilize the SUS belong to more socially vulnerable groups [29,30].

However, given the limited number of Brazilian publications assessing users' per- ceptions of SUS services since 2020 [28,29], low response rates in previous studies [29,30], and the restriction of previous studies to specific topics, e.g., only pharmaceutical services or primary care, more up-to-date research is needed to reflect the importance of social participation in identifying population demands and needs. There is also a need to focus on a broader view of users' perceptions of various aspects of public health across primary care, pharmaceutical services, and challenges associated with access to specialized services. In addition, the state of Rio de Janeiro—a strategic region in Brazil due to its tourism, eco- nomic, and cultural significance—faces unique challenges related to access to and quality of SUS services [31].

Consequently, a research project titled "*Assessment of Access and Quality of Public Health Services from the Perspective of the Unified Health System*" has been underway since 2023 at the Federal University of Rio de Janeiro [15–17]. Among the regions and the interior of the state of Rio de Janeiro. Previous phases of the project have been published, including analyses from the Coastal Lowlands [16], the metropolitan region [17], and a municipality in the Northern Fluminense region [15].

This study focuses on the five regions within the state of Rio de Janeiro: metropolitan region, Coastal Lowlands, Northern Fluminense, Mountain, and Middle Paraíba. The research aimed to engage with the population by conducting face-to-face interviews in various high-traffic locations across municipalities in both metropolitan regions and the interior of the state of Rio de Janeiro. This paper aims to analyze the perceptions of

residents in these five regions regarding their access to, and the quality of, the public health system, including primary care and pharmaceutical services. Furthermore, the study aims to highlight the disparities observed among the five regions of the state of Rio de Janeiro, Brazil, associated with the provision of services in PHC, specialized care, and the pharmaceutical sector. The study also explores the main challenges faced by SUS users and their perceptions of the pharmacist's role in health services. The findings can be used to give guidance to all key stakeholder groups in Brazil regarding potential ways to improve services in the future.

2. Methods

2.1. Study Design and Setting

A cross-sectional study was conducted to evaluate the perceptions of residents from five regions of the state of Rio de Janeiro (Figure 1)—Metropolitan, Coastal Lowlands, Northern Fluminense, Mountain, and Middle Paraíba—regarding different aspects of SUS services. Because the study had no external funding and no financial resources to support the interviews, a convenience sampling was used. This took into account factors such as ease of access and travel within the municipality selected and the possibility for interviews to be conducted by undergraduate students, i.e., in municipalities where they reside and/or have family members who are part of the research project team.

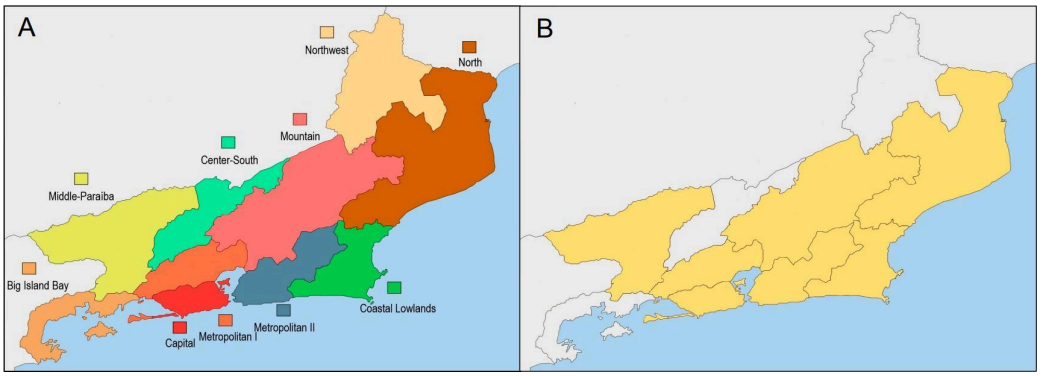

Figure 1. (**A**) Regions of Rio de Janeiro State in Brazil. (**B**) Regions participating in the study. Note: The regions of the state of Rio de Janeiro involved in this study are highlighted in yellow (**B**).

According to IBGE data, the state of Rio de Janeiro has approximately 17 million inhabitants, divided into nine regions and 92 municipalities [32]. For this study, the regions were analyzed according to the political-administrative division into health regions. The metropolitan region (I and II) accounts for 75.4% of the state's population and includes 19 municipalities: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópo- lis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Seropédica, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim, and Tanguá [33,34]. Among these, three municipalities were selected as a purposive convenience sample for this study: the state capital (Rio de Janeiro), São Gonçalo, and Duque de Caxias. Together, they represent 68.9% of the region's population.

The Northern Fluminense region comprises 5.7% of the state's population and includes 8 municipalities: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, and São João da Barra [35]. For this study, Campos dos Goytacazes and Macaé were selected as a convenience sample, representing 52.3% of the region's population.

The Coastal Lowlands region accounts for 5.1% of the state's population and includes 9 municipalities: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro

de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, and Saquarema [36]. The municipalities of Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, and São Pedro da Aldeia were chosen as a convenience sample, covering 61.2% of the region's population.

The Middle Paraíba region represents 5.4% of the state's population and includes 12 municipalities: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, and Volta Redonda [37]. Questionnaires were collected in all municipalities of this region.

The Mountain region accounts for 6.0% of the state's population and includes 16 municipalities: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis, and Trajano de Morais [38]. In this context, Nova Friburgo, Cantagalo, and Cordeiro were included in the study, repre- senting 21.1% of the region's population.

2.2. Data Collection Instrument

The research instrument was developed by the project team based on previous federal government projects: the National Program for Improving Access and Quality of Primary Care (PMAQ) [23,25–27] and the National Survey on Access, Use, and Promotion of the Rational Use of Medicines (PNAUM) [22,24] (Supplementary Material). In the development phase, the focus was on developing simple, objective, and easy-to-understand questions, following the profile of those adopted in the previously cited instruments [23,25–27]. The final questionnaire consisted of 66 questions, and the same instrument was applied across all five regions of the state of Rio de Janeiro included in this study. Aspects such as difficulties in the use of medicines, types of public health services utilized, and perceptions of SUS and other approaches were included.

The 66 questions were organized into the following four sections: (A) socioeconomic profile and use of health services; (B) clinical condition; (C) use of medicines; and (D) perceptions and use of public health services. It is important to emphasize that only participants who reported using SUS services answered Section D (step two: assessing users' perceptions of access to and quality of SUS services), whereas the previous sections (A, B, and C) were completed by all participants (n = 1000).

Section D aimed to explore participants' perceptions of different aspects of SUS services. It included several questions related to access to and quality of public health services, the types of services most frequently used, the need to seek health care in a municipality other than their place of residence, and other related topics. In addition, we included questions addressing the pharmaceutical context, with particular emphasis on medication use, participants' experiences with medicine usage instructions, the acquisition and use of over-the-counter (OTC) medicines, and other relevant aspects. Additional questions sought to assess whether participants fully understood their prescriptions, including instructions for antibiotic use and polypharmacy.

To enhance the robustness of the questionnaire, it was pre-tested with 30 individuals from the municipality of Macaé (Northern Fluminense Region), near the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ-Macaé). During the pre-test, we confirmed that no questions required modification.

2.3. Data Collection and Inclusion Criteria

The sample size was calculated to estimate a proportion with a maximum margin of error of approximately 3% at a 95% confidence level, assuming the scenario of greatest variability (i.e., when the population proportion equals 0.50). This resulted in an esti-

mated sample size of approximately n = 1000 participants, using the equation $n = 1/(d^2)$, distributed among the municipalities proportionally to their population sizes [39].

Because the project had no available funding, municipalities and regions of the state of Rio de Janeiro with greater accessibility and feasibility for the interview team were selected as a purposive convenience sample. Inclusion criteria required participants to be 18 years of age or older. For analyses evaluating the quality of public health services, individuals who reported never having used the SUS were excluded.

Data collection was carried out by undergraduate students from the Institute of Pharmaceutical Sciences at the Federal University of Rio de Janeiro/Macaé, who had been previously trained by the study's coordinating professor. Interviews took place in public and freely accessible areas, generally near healthcare facilities, including municipal pharmacies, hospitals, and Basic Health Units (UBSs). These locations were intentionally selected to maximize the recruitment of participants who were users of the SUS or private health insurance, maximizing the inclusion of diverse experiences and perspectives. It should be noted that the interviewers randomly invited individuals from various high- traffic locations within each selected municipality in order to include participants with different socioeconomic profiles. The recruitment strategy aimed to approach individuals who were likely to have recent or ongoing contact with health services, particularly those present in healthcare settings at the time of data collection.

2.4. Data Analysis

Data analysis consisted of a descriptive assessment of participants' responses, including questions on sample characteristics such as gender, age, education level, household income, and clinical profile, which are presented in tables and graphs. In addition, anal- yses were performed on utilization patterns and perceptions of public health services, with a primary focus on PHC, and included the specialized care and pharmaceutical ser- vices. To present the income profile of the interviewees, values in BRL were converted to USD using the exchange rate provided by the Central Bank of Brazil (2025), which was USD 1 = BRL 5.87 [34,40].

Additionally, users' experiences in the pharmaceutical context were evaluated, covering the entire process of acquiring and using medicines, including over-the-counter (OTC) and prescription drugs, challenges related to polypharmacy, and patients' perceptions of the pharmacist's role in health care. Variables were summarized using absolute and relative frequencies, and associations between them were analyzed using Pearson's chi-square test. Results were considered statistically significant when the p-value was <0.05. Analyses were conducted using Microsoft Excel 365 and R software, version 4.3.0.

In addition, we evaluated a potential association between participants' gender, educational level, skin color, and family income and their perceptions of access to and quality of SUS services.

2.5. Ethical Aspects

Participation was voluntary, and research objectives were explained to participants, including a reading of the Informed Consent Form (ICF). Individuals who agreed to participate signed two copies of the ICF, one retained by the participant and the other by the researcher. Once the form was signed, the questionnaire was administered.

The present study was approved by the Ethics and Research Committee of the Federal University of Rio de Janeiro/Macaé Campus (CAAE: 68864623.6.0000.5699).

3. Results

3.1. Participant Characteristics

Based on the analysis of the 1000 questionnaires, it was observed that the sample was predominantly female (66.2%), with an average age range of 25 to 45 years (41.5%), and most participants had completed high school (33.8%).

The majority of participants reported using SUS services (92.1%), as shown in Table 1.

Table 1. Characteristics of study participants (n = 1000).

Variable	*n*	(%) *
Gender *		
Female	659	66.2%
Male	337	33.8%
Age Profile (years old)		
18–25	166	16.6%
26–45	415	41.5%
46–60	255	25.5%
More than 60	163	16.3%
Race/skin color **		
White	385	39.4%
Black	196	20.0%
Brown	390	40.0%
Other	6	0.6%
Education level ***		
Never attended school	15	1.5%
Incomplete elementary school	141	14.5%
Completed elementary school	72	7.4%
Incomplete high school	56	5.7%
Completed high school	390	40.0%
Incomplete college	145	15%
Completed college or more	156	16.0%
Family Income **** (Number of times the minimum wage *****)		
Up to 1	161	18.4%
1–2	221	26.0%
2–3	216	25.4%
3–5	264	19.3%
5–10	72	8.5%
10–20	14	1.6%
>20	3	0.4%
Use of SUS services—Yes	927	93.6%
Has a private health plan—Yes	314	31.7%

Notes: * Gender: 0.4% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer");
** Race/Skin Color: 2.3% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer");
*** Education level: 2.5% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer");
**** Family income: 14.9% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer");
***** Minimum wage in 2024: BRL 1412.00 (US $254.41).

Among the services offered by SUS used by the participants, vaccination and medical consultations were the most frequently utilized services (25.1% and 23.6%, respectively), followed by the acquisition of medications (14.5%), as illustrated in Figure 2.

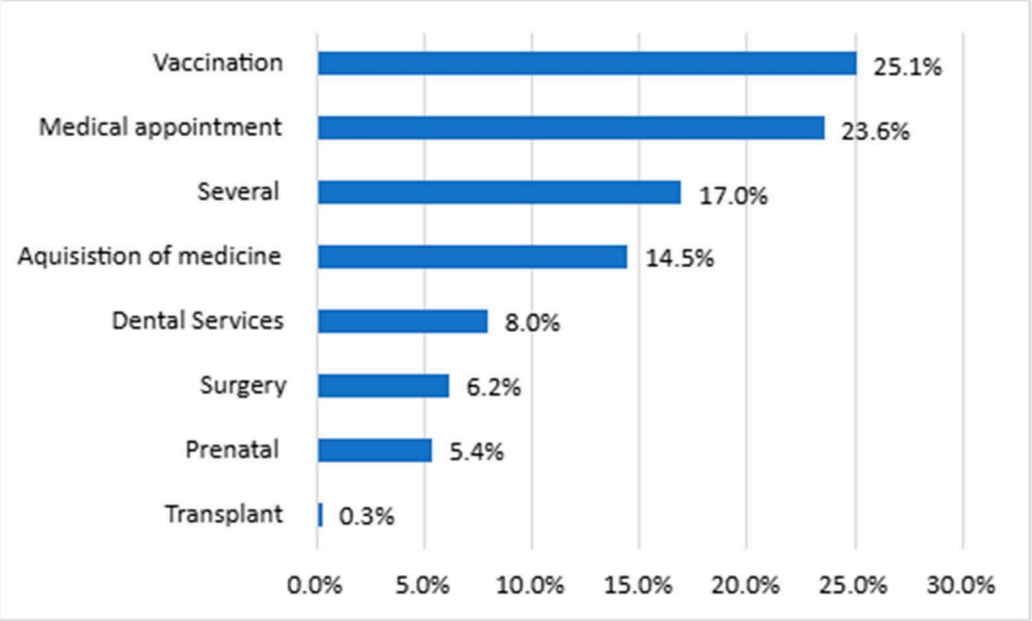

Figure 2. Most commonly used SUS services reported by users from the State of Rio de Janeiro (n = 1000). Note: Respondents were allowed to report more than one difficulty.

25.3% of the sample reported having no difficulties in obtaining or using their medications. However, the greatest challenges identified were remembering the time to take medications (22.1%), obtaining the medication (13.3%), and adjusting medication use with their work routine (11.3%), as shown in Figure 3.

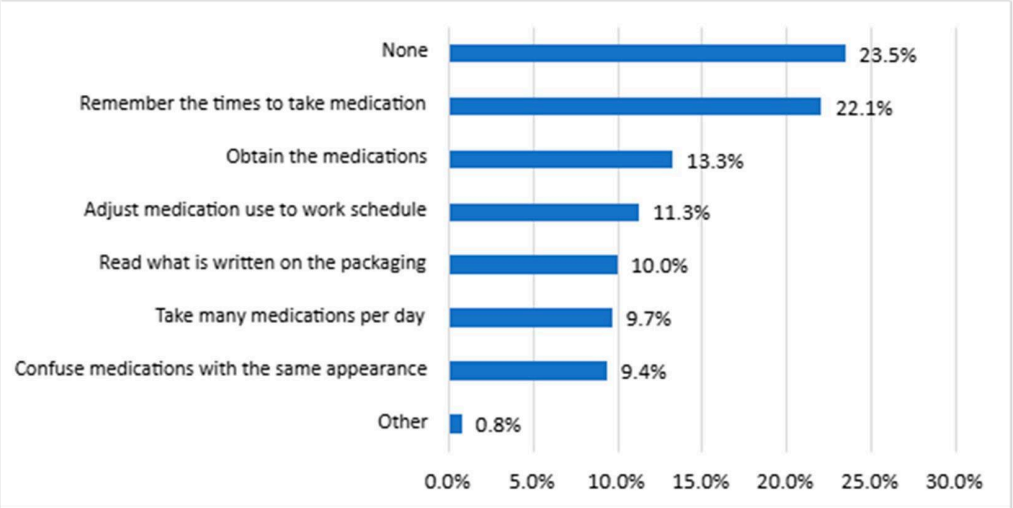

Figure 3. Difficulties reported by respondents associated with the use of medicines (n = 1000). Note: respondents could record more than one service.

3.2. Responses from SUS Users

990 (99%) of the sample reported that they currently use or have previously used SUS and thus answered questions relating to the second part of the questionnaire. When asked about medical consultations, 47.4% stated that they rely solely on SUS services, 33.3% use both SUS and private health insurance, and 14.0% reported using only private health insurance for consultations. The remaining 5.3% of respondents did not answer these questions (don't know/don't want to answer).

Most SUS users consider it indispensable and essential, with this view shared by those who always use the system (90.8%) as well as those who use it rarely (82.1%). Among those who always use the system, 40.6% rated access to SUS services as good and 31.9% as neither good nor bad. Occasional and non-users rated access as neither good nor bad (39.0% and 47.8%, respectively). When asked about the quality of services, those who always use the system described it as very good/good, while the most negative evaluations came from those who rarely or never use the system (24.2%), as shown in Table 2.

Table 2. Perceptions of SUS users regarding the relevance, access to, and quality of the public health services (n = 990).

Relevance of SUS n (%) *				
Frequency	**Indispensable**	**Complementary**	**Indifferent**	***p*-Value**
Always	364 (90.8%)	29 (7.2%)	8 (2.0%)	
Frequently	112 (86.2%)	16 (12.3%)	2 (1.5%)	
Sometimes	219 (85.9%)	27 (10.%)	9 (3.5%)	0.056
Rarely	156 (82.1%)	24 (12.6%)	10 (5.3%)	
ALL	851 (87.2%)	96 (9.8%)	29 (3.0%)	

Access to SUS Services n (%) **						
Frequency	**Very Good**	**Good**	**Neither Good nor Bad**	**Bad**	**Very Bad**	***p*-Value**
Always	32 (8.2%)	159 (40.6%)	125 (31.9%)	54 (13.8%)	22 (5.6%)	
Frequently	6 (4.8%)	55 (44.0%)	43 (34.4%)	13 (10.4%)	8 (6.4%)	
Sometimes	10 (4.0%)	68 (27.3%)	97 (39.0%)	55 (22.1%)	19 (7.6%)	0.002
Rarely	10 (7.6%)	48 (36.4%)	38 (28.8%)	24 (18.2%)	12 (9.1%)	
Never	1 (2.2%)	10 (21.7%)	22 (47.8%)	8 (17.4%)	5 (10.9%)	
ALL	59 (6.3%)	340 (36.0%)	325 (34.4%)	154 (16.3%)	66 (7.0%)	

Quality of SUS Services n (%) ***				
Frequency	**Very Good/Good**	**Neither Good nor Bad**	**Bad/Very Bad**	***p*-Value**
Always	196 (48.6%)	135 (33.5%)	72 (17.9%)	
Frequently	66 (50.8%)	49 (37.7%)	15 (11.5%)	
Sometimes	92 (36.7%)	103 (41.0%)	56 (22.3%)	0.003
Rarely/Never	65 (35.7%)	73 (40.1%)	44 (24.2%)	
ALL	419 (43.4%)	360 (37.3%)	187 (19.4%)	

Notes: * 1.4% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer"); ** 4.6% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer"); *** 2.4% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer").

Regarding perceptions of access, the Middle Paraíba and metropolitan regions received the most favorable evaluations, with 57.8% and 56.5% of respondents rating access as very good/good, respectively. In contrast, access was rated poorest (poor/very poor) in the Coastal Lowlands region, with 36.3% of users reporting negative perceptions, as shown in Figure 4. A similar pattern was observed in evaluations of service quality: the Middle Paraíba and metropolitan regions again showed the most positive responses (very good/good) from 57.0% and 53.7% of participants, respectively, while the Coastal Lowlands region had the most negative evaluations, with 30.9% rating quality as poor/very poor.

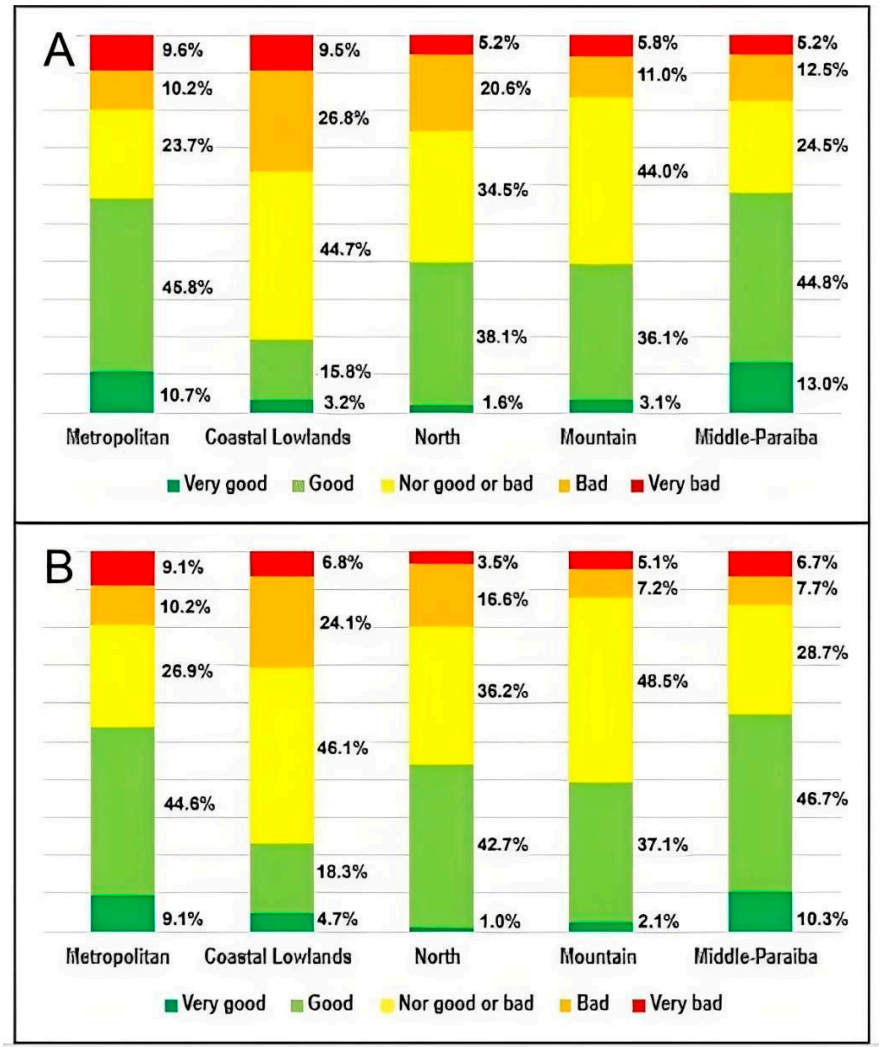

Figure 4. (**A**) Perception of access to SUS services in each region. (**B**) Perception of the quality of health services in each region. (n = 990). Notes: 11.7% of participants did not answer this question ("don't know/don't want to answer"); 17.3% of participants did not answer this question ("don't know/don't want to answer").

No statistically significant correlation was observed between perceptions of access to and quality of health services and factors such as gender, family income, or skin color (p-value > 0.05).

More favorable evaluations of access to, and quality of, health services were predominantly reported by participants with lower household incomes, with a significant association found between household income and perceptions of access to SUS services (p = 0.001), according to Table 3. Among respondents earning less than the minimum wage, 56.0% rated access as "very good" or "good." Regarding service quality, 53.5% of participants in this income group rated it as "very good" or "good," whereas 45.8% of those earning more than three minimum wages rated it as "neither good nor bad."

Table 3. Views of SUS users regarding the access to and quality of the public health services associated with family income (n = 990).

Access to SUS Services n (%)				
Family Income (Number of Times the Minimum Wage)	**Very Good/Good**	**Nor Good nor Bad**	**Bad/Very Bad**	***p*-Value**
Up to 1	88 (56.0%)	35 (22.3%)	34 (21.7%)	
1–2	80 (37.7%)	76 (35.8%)	56 (26.4%)	
2–3	85 (42.1%)	70 (34.6%)	47 (23.3%)	0.001
3–4	53 (34.2%)	62 (40.0%)	40 (25.8%)	
>4	28 (33.3%)	39 (46.4%)	17 (20.3%)	
TOTAL *	334 (41.2%)	282 (34.8%)	194 (24.0%)	
Quality of SUS Services n (%)				
Family Income (Number of Times the Minimum Wage)	**Very Good/Good**	**Nor Good nor Bad**	**Bad/Very Bad**	***p*-Value**
Up to 1	85 (53.5%)	49 (30.8%)	25 (15.7%)	
1–2	90 (41.5%)	80 (36.9%)	47 (21.6%)	
2–3	87 (41.0%)	84 (39.6%)	41 (19.3%)	0.164
3–4	62 (39.5%)	63 (40.1%)	32 (20.4%)	
>4	29 (34.9%)	38 (45.8%)	16 (19.3%)	
TOTAL **	353 (42.6%)	35 (37.9%)	161 (19.5%)	

Notes: * 81.8% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer"); ** 55.5% of participants did not answer these questions ("don't know/don't want to answer").

Regarding how medications are obtained, 47.6% of participants reported acquiring them exclusively from private pharmacies, 40.5% obtained their medications from both private and public pharmacies, and only 9.7% reported acquiring them exclusively from public pharmacies. When asked about the role of pharmacists, the majority of those who obtained medications through the public system (either exclusively or partially) considered the pharmacist's role essential (82.7%), while 12.3% found it indifferent. Among those who acquired medications solely through private pharmacies, 58.1% viewed the pharmacist as essential, whereas 41.9% considered their role indifferent.

Among those who acquired medications from public pharmacies only (n = 497), 26.8% reported never receiving guidance on how to use them, and 53.7% stated they had never received instructions on how to store their medicines. Furthermore, 40.1% said there was at least one staff member available at the pharmacy to answer questions about medications, while 41.8% said they had never encountered a pharmacist at public health units, as shown in Table 4.

Table 4. Views of SUS users regarding acquiring medications in public pharmacies (n = 497).

	Answers %				
Questions	**Always**	**Frequently**	**Sometimes**	**Rarely**	**Never**

When you pick up medications at public pharmacies of the SUS, do the staff who dispense the medications provide information and/or guidance on how to use them? *	146 (29.8%)	107 (21.9%)	67 (13.7%)	38 (7.8%)	131 (26.8%)	489 (100.0%)
When picking up medications at public pharmacies of the SUS, do you receive guidance on how to store them at home? **	68 (14.0%)	45 (9.2%)	64 (13.2%)	48 (9.9%)	261 (53.7%)	486 (100.0%)

Table 4. *Cont.*

Questions	Answers %					
	Always	Frequently	Sometimes	Rarely	Never	Total
Is the pharmacist or another staff member at public pharmacies of to ask questions about medications? ***	170 (40.1%)	87 (20.5%)	82 (19.3%)	25 (5.9%)	60 (14.2%)	424 (100.0%)
Have you ever encountered a pharmacist at the public facility you visit (ESF, UBS, or medication the SUS available when you need dispensing unit)? ****	61 (15.7%)	76 (19.6%)	57 (14.7%)	32 (8.2%)	162 (41.8%)	388 (100.0%)

Notes: * 1.6% of participants did not answer this question ("don't know/don't want to answer"); ** 2.2% of participants did not answer this question ("don't know/don't want to answer"); *** 14.7% of participants did not answer this question ("don't know/don't want to answer"); **** 21.9% of participants did not answer this question ("don't know/don't want to answer").

4. Discussion

Public health services offered by SUS play a vital role for the Brazilian population, especially through primary care, which serves as the main entry point to the healthcare system. This paper shows that 93.3% of the sample reported using SUS, with those who most frequently used SUS services rating access more positively than those who used SUS less (p-value = 0.002). Participants with lower socioeconomic status also provided more favorable assessments of access to public health services (p = 0.001). Moreover, 25.1% of respondents reported using SUS for vaccination and 23.6% for medical consultations, highlighting its role in the health system.

These findings resonate with recent data from across Brazil [30], which highlights the importance of SUS in serving socially vulnerable groups and the most disadvantaged populations. This underscores the need for public policies that promote equity and address socioeconomic and geographic disparities to improve access to and quality of public health services. A high family income was the main characteristic observed in the profile of the population that reported not using SUS services, with 6.4% in this study, focusing on the state of Rio de Janeiro, and 10.7% in a national sample [29,30].

Among frequent users of SUS services, 90.8% view

it as indispensable, while 82.1% of those who rarely use it share the same opinion. However, when asked about access, users who reported "always" or "frequently" using SUS expressed more favorable percep- tions, with 40.6% and 44.6% rating it as "good," respectively. These findings align with others, which showed that despite recognized issues in health services, users often express satisfaction with the available services [41,42].

When questioned about the quality of SUS services, 50.8% of frequent users rated the system as "very good," while 44% gave a neutral evaluation ("neither good nor bad"). In contrast, among those who rarely use public healthcare services, 24.2% rated it as "poor." These results suggest that those who use the SUS services tend to have a more positive perception compared to those who use it less frequently and may instead rely on private health plans. Similar results were seen in 2019 [41]. This is similar to the findings of the São Paulo State Department of Health, where 60.6% of hospitalized users rated the care they received as good [43]. However, 74% of those surveyed stated they faced some type of barrier when accessing healthcare services. These combined findings underscore the challenges faced by the SUS in meeting the growing demand for quality care.

In 2018, 39% of patients with chronic diseases obtained their medications from public pharmacies, with the majority of people obtaining their medicines from private pharmacies

(including popular pharmacy programs) or a combination of public and private sources [44]. This study found that only 9.7% of respondents reported acquiring medications from public facilities. This disparity may be attributable to regional variations, indicating suboptimal access to medicines in public facilities within the state of Rio de Janeiro. Furthermore, given that the popular pharmacy program is administered through private pharmacies [45], respondents may have reported obtaining medications from private pharmacies even if they were procured via this public policy initiative. We will be following this up in future studies.

Among participants who obtained medications from public pharmacies in this study, the majority (82.7%) recognized the role of pharmacists as essential, even though the broader role of pharmacies is often underestimated by the public [10].

When asked about receiving guidance when obtaining medications, 26.85% of respondents stated that they had never received such guidance, and 53% reported never having received information on how to store medications or the necessary precautions. Additionally, 48.1% had never seen a pharmacist providing guidance in a UBS, Family Health Strategy (ESF), or dispensing location. A study conducted during the pandemic showed that although 95% of people perceive the pharmacist as a healthcare professional, 68.6% did not seek guidance from them, and 53.4% had never seen one [46]. This indicates an apparent disconnect between the perceived role of the pharmacist and the full utilization of their services. The lack of pharmacist presence in UBS and ESF contributes to this situation, with only 15% of UBS having a pharmacist. In the units that do have these profession- als, there is better medication distribution and greater availability [46]. These findings provide guidance to community pharmacies going forward to help improve medicine use in the country and underscore the importance of continued investment in this critical health sector [47].

While 93.3% of participants reported using SUS, 31.7% reported having private health insurance, above the national average of 25%, according to the National Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans [48]. The higher percentage of participants who have private health insurance, compared to that expected in the country, may be associated with a better socioeconomic status and/or formal employment profile in our sample. Many Brazilians have private health insurance, based on facilities and/or benefits involving their respective companies (e.g., multinationals, state-owned companies, and service sector). Income concentration and employment opportunities are some of the incentives with which individuals seek private health coverage for their families [12]. Notably, the Coastal Lowlands and the North Fluminense regions reported the highest reliance on SUS. This is not only due to socioeconomic factors but also because the access to, and quality of, public healthcare services often influence whether users turn to private services instead [49].

The five regions in the state of Rio de Janeiro revealed varying perceptions of the health system. The Lagos region rated access and quality more negatively compared to the metropolitan region, which showed more favorable evaluations. This was also seen in the Norte Fluminense region, where a larger share of the population uses private health insurance, whereas the metropolitan region relies more heavily on the public system. Furthermore, some regions, including the Coastal Lowlands and Mountains, face shortages of UBS and ESF services. A related study conducted within this same research project in the Coastal Lowlands region [16] demonstrated that the lack of Primary Health Care units, as well as the absence of pharmacists in facilities such as UBS, has negatively impacted the population's perception of access to and quality of health services. In addition to the findings of this study and others conducted by the same research group, it is important to note that although users' perceptions are somewhat positive, public opinion can be significantly influenced by digital media [50]. In this context, negative aspects such as

delays in care and medical errors receive greater visibility, while the system's strengths and achievements are often downplayed or overlooked [50]. As a result, SUS has become a target of political and social attacks that threaten its structure and put at risk the continuation of one of the most important programs in the country's history, representing a step backward in light of the progress already made in public health [50]. Consequently, it is essential to understand social demands and, above all, to develop strategies that ensure SUS is responsive to population needs and in receipt of broad social support.

Among our results, we observed that 10.5% of participants had a family income of ≥ five times the minimum wage, 60% self-identified as Black or Brown, and only 16.3% were elderly (>60 years old), according to the Brazilian classification [51]. Data from the latest demographic census of Rio de Janeiro indicate that the combined percentage of the Black and Brown population was higher than other groups across all regions of the state [32,52], with a higher proportion of women and a lower percentage of individuals over 60 [32,52], characteristics also observed in our study. Some published studies, although they did not include statistical analyses correlating respondents' perceptions of SUS services with socioeconomic characteristics (i.e., income and education), generally observed a predominance of participants who self-identified as Black and/or brown, along with a low percentage of individuals with higher education and/or higher income [42,53,54], which is a demographic profile similar to our study.

We acknowledge that this study has some limitations, including the use of purposive convenience sampling. This strategy was adopted due to the impossibility of conducting probability sampling in a large and heterogeneous target population, composed of hundreds of thousands of SUS users. Given the lack of a unified and accessible registry of these users for random selection purposes, the questionnaire was administered to participants who were in or near health services at the time of data collection. Although this approach limits the statistical generalization of the findings to the entire SUS user population, it is frequently employed in applied health research [39,55], particularly when investigating subjective perceptions and experiences, as in the assessment of access to and quality of health services [56,57]. Furthermore, strict inclusion and exclusion criteria were applied, and efforts were made to ensure diversity in the sociodemographic profiles of participants, which we believe contributes to the internal validity of the study. In addition, considering that the study involved undergraduate students from a public university in Brazil and that the project had no available funding, the municipalities and regions of the state of Rio de Janeiro selected for participation were those with greater accessibility and feasibility in terms of transportation, accommodation, and food, allowing interviews to be conducted by a team of volunteer interviewers. Due to logistical challenges, it was not possible to include all municipalities or some localities that could have enhanced regional representation, as in the case of the mountain region, which accounts for approximately 21% of the population. Nonetheless, we prioritized areas with greater socioeconomic relevance, aiming to foster meaningful reflections on the topic within the state context. Furthermore, as a descriptive study, it has certain limitations, such as focusing on describing the findings rather than testing hypotheses or explaining mechanisms, which limits the potential for generalization [58]. However, considering the scarcity of publications on the topics addressed, coupled with the appreciable numbers of participants in this study, we believe our findings will contribute to future discussions on the regional challenges of promoting public health services within a universal system.

Overall, we believe our study offers valuable contributions to the planning and development of public health initiatives, particularly in the context of one of Brazil's most important states as well as the other regions in Brazil facing similar challenges. Research efforts and initiatives such as projects or strategies that foster dialogue and promote the "ac-

tive listening" of SUS users are essential for informed decision-making by health managers. These insights into user experiences can help guide the implementation and improvement of services to better meet the needs of the population. The results may also be of interest to other countries that face socioeconomic challenges and share the goal of expanding access to quality health services for their populations.

5. Conclusions

The research showed that the population of Rio de Janeiro state perceives the SUS as an essential public service, and access to and the quality of services are evaluated highly, especially by its most frequent users. It also revealed significant regional disparities within the state, particularly regarding services provided by Primary Health Care (PHC) and pharmaceutical services. Promoting research and strategies that foster continuous, constructive dialogue between the population and decision-makers is essential for developing more effective public policies tailored to local needs. To maintain the quality of health service delivery, continuous, constructive dialogue between the population and decision-makers is needed, emphasizing the importance of local engagement in ensuring both access to and the quality of services delivered by municipalities within the Brazilian federal context.

This study covered five of the seven regions of one of Brazil's largest states. Despite being located in the Southeast, a region with more favorable socioeconomic conditions compared to the North and Northeast, user perceptions indicate that many difficulties and challenges persist, such as the provision of specialized care, especially in inland areas such as the Coastal Lowlands region. These findings reflect the real challenges faced by users and have implications for public management so that principles such as universality and comprehensiveness can be effectively achieved in practical settings.

The poor results of access to medicines in Rio de Janeiro state public facilities in comparison to national research necessitate more research to be performed to investigate this further. Finally, the need for the presence of pharmacists in community pharmacies, UBS, and ESF has been highlighted given their capacity to positively influence health indicators and the quality of life of users in alignment with the constitutional principles on which the SUS was founded.

Supplementary Materials: The following supporting information can be downloaded at: https://www.mdpi.com/article/10.3390/ijerph22091424/s1, Survey Instrument.

Author Contributions: Conceptualization, I.P.D.G.; methodology, I.F.L.F., M.C.R., E.A.R., and I.P.D.G.; software, I.F.L.F., M.C.R., E.A.R., and I.P.D.G.; validation, I.F.L.F., M.C.R., N.M.A.M.B., J.S.S., B.M.V.L., T.P.T., D.M.d.S.S.d.S., L.A.C., B.G., S.M.C., J.C.M., I.P.D.G., and I.F.L.F.; formal analysis, I.F.L.F., M.C.R., N.M.A.M.B., J.S.S., B.M.V.L., T.P.T., D.M.d.S.S.d.S., L.A.C., B.G., S.M.C., J.C.M., and I.P.D.G.; investigation, I.F.L.F., E.A.R., and I.P.D.G.; resources, I.F.L.F., M.C.R., N.M.A.M.B., J.S.S., B.M.V.L., T.P.T., D.M.d.S.S.d.S., L.A.C., B.G., S.M.C., J.C.M., and I.P.D.G.; data curation, I.F.L.F., E.A.R., and I.P.D.G.; writing original draft preparation, I.F.L.F., M.C.R., N.M.A.M.B., J.S.S., B.M.V.L., T.P.T., D.M.d.S.S.d.S., L.A.C., B.G., S.M.C., J.C.M., and I.P.D.G. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Conflicts of Interest: The authors have no relevant affiliations or financial involvement with any organization or entity with a financial interest in or financial conflict with the subject matter or materials discussed in the manuscript. This includes employment, consultancies, honoraria, stock ownership or options, expert testimony, grants or patents received or pending, or royalties. No writing assistance was utilized in the production of this manuscript.

References

1. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Dispõe Sobre as Condições Para a Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, a Organização e o Funcionamento dos Serviços Correspondentes e dá Outras Providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 September 1990. Available online: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm (accessed on 9 August 2025).
2. Brasil. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe Sobre a Participação da Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde (sus) e Sobre as Transferências Intergovernamentais de Recursos Financeiros na Área da Saúde e dá Outras Providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 December 1990. Available online: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm (accessed on 9 August 2025).
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *OECD Reviews of Health Systems: Brazil 2021*; OECD Publishing: Paris, France, 2021; Available online: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-reviews-of-health-systems-brazil-2021_146d0dea-en.html (accessed on 5 August 2025).
4. Physis. Regionalização em Saúde no Brasil: Uma Análise da Percepção dos Gestores de Comissões Intergestores Regionais. *Physis Rev. Saúde Coletiva* **2022**, *32*, 1–23. [CrossRef]
5. Ministério da Saúde. *Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010. Estabelece Diretrizes Para a Organização da Rede de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde (sus)*; Diário Oficial da União, Ministério da Saúde: Brasília, Brazil, 2010.
6. Elidio, G.A.; Sallas, J.; Pacheco, F.C.; de Oliveira, C.; Guilhem, D.B. Atenção primária à saúde: A maior aliada na resposta à epidemia da dengue no Brasil. *Rev. Panam. Salud Publica* **2024**, *48*, e47. [CrossRef] [PubMed]
7. Bousquat, A.; Akerman, M.; Mendes, A.; Louvison, M.; Frazão, P.; Narvai, P.C. Pandemia de covid-19: O SUS mais necessário do que nunca. *Revista USP* **2021**, *1*, 13–26. [CrossRef]
8. Brasil. *Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica*; Ministério da Saúde: Brasília, Brazil, 2017. Available online: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2017.pdf (accessed on 17 June 2025).
9. Ministério da Saúde. *Estratégia e-Multi: Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde*; Ministério da Saúde: Brasília, Brazil, 2022.
10. Peixoto, R.T.; Campos, M.R.; Luiza, V.L.; Mendes, L.V. O farmacêutico na Atenção Primária à Saúde no Brasil: Análise comparativa 2014-2017. *Saúde Debate* **2022**, *46*, 358–375. Available online: https://revista.saudeemdebate.org.br/sed/article/view/6410 (accessed on 17 June 2025). [CrossRef]
11. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. ANS Divulga Dados de Beneficiários Referentes a Agosto de 2024. Brasília, Brazil. 2024. Available online: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/ans-divulga-dados-de-beneficiarios-referentes-a-agosto-de-2024 (accessed on 10 October 2024).
12. Souza Júnior, P.R.B.; Szwarcwald, C.L.; Damacena, G.N.; Stopa, S.R.; Vieira, M.L.F.P.; Almeida, W.S.; Oliveira, M.M.; Sardinha, L.M.V.; Macário, E.M. Cobertura de plano de saúde no Brasil: Análise dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013 e 2019. *Ciência Saúde Coletiva* **2021**, *26*, 2529–2541. [CrossRef]
13. Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Estado do Rio Tem a pior Cobertura de Atenção Básica do sus no país; Piauí, a melhor: Veja o ranking. [S.l.: S.n.]. 2025. Available online: https://ieps.org.br/estado-do-rio-tem-a-pior-cobertura-de-atencao-basica-do-sus-no-pais-piaui-a-melhor-veja-o-ranking/ (accessed on 15 January 2025).
14. Economist Impact. The Road to Health Inclusivity: From Policy to Practice. 2023. Available online: https://impact.economist.com/projects/health-inclusivity-index/documents/the_road_to_health_inclusivity_health_inclusivity_index_2023_economist_impact_final.pdf (accessed on 9 August 2025).
15. Dornas, B.S.S.; Reis, E.A.; Campos, A.A.O.; Godói, I.P.D. Percepções sobre os serviços de saúde pública em macaé-rj: Um estudo transversal. *Rev. Saúde Pública Paraná* **2024**, *7*, 1–20. [CrossRef]
16. Souza, J.S.; Reis, E.A.; Godman, B.; Campbell, S.M.; Meyer, J.C.; Sena, L.W.P.; Godói, I.P.D. Users' perceptions of access to and quality of unified health system services in brazil: A cross-sectional study and implications to healthcare management challenges. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2024**, *21*, 721. [CrossRef]
17. Raimundo, M.C.; Reis, E.A.; Ferraz, I.F.L.; Borges de Almeida, C.P.; Godman, B.; Campbell, S.M.; Meyer, J.C.; Godói, I.P.D. Users' perceptions of access to and quality of public health services in brazil: A cross-sectional study in metropolitan rio de janeiro, including pharmaceutical services. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2025**, *22*, 967. [CrossRef]
18. Picorelli, L.F. o papel da participação comunitária no sus. *Rev. Direito Med.* **2019**, *1*, 1–20. Available online: https://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2022/06/01/13_19_11_463_O_papel_da_participa_o_comunit_ria_no_SUS.pdf (accessed on 17 January 2025).
19. Caring for Canadians: Canada's Future Health Workforce—The Canadian Health Workforce Education, Training and Distribu- tion Study. 2025. Available online: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/health-human-resources/workforce-education-training-distribution-study.html (accessed on 6 August 2025).
20. HS England. Working in Partnership with People and Communities: Statutory Guidance. London: NHS England, Updated 2023. Available online: https://www.england.nhs.uk/long-read/working-in-partnership-with-people-and-communities-statutory-guidance/ (accessed on 6 August 2025).

21. Vital Strategies, Umane, Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Resolve to Save Lives. More Data Better Health: Acesso e Percepção da População Brasileira Sobre a Atenção Primária à Saúde, Módulo 1. São Paulo, Brazil. 2025. Available online: https://www.vitalstrategies.org (accessed on 6 August 2025).
22. Gadelha, C.A.; Costa, K.S.; Nascimento, J.M., Jr.; Soeiro, O.M.; Mengue, S.S.; Motta, M.L.; Carvalho, A.C. PNAUM: Integrated approach to pharmaceutical services, science, technology and innovation. *Rev. Saude Publica* **2016**, *50* (Suppl. 2), 3s. [CrossRef]
23. Fardousi, N.; Nunes da Silva, E.; Kovacs, R.; Borghi, J.; Barreto, J.O.; Kristensen, S.R.; Sampaio, J.; Shimizu, H.E.; Gomes, L.B.; Russo, L.X.; *el al*. Performance bonuses and the quality of primary health care delivered by family health teams in brazil: A difference-in-differences analysis. *PLoS Med.* **2022**, *19*, e1004033. [CrossRef]
24. Mengue, S.S.; Bertoldi, A.D.; Boing, A.C.; Tavares, N.U.L.; Pizzol, T.D.S.D.; Oliveira, M.A.; Arrais, P.S.D.; Ramos, L.R.; Farias, M.R.; Luiza, V.L.; *el al*. National survey on access, use and promotion of rational use of medicines (PNAUM): Household survey component methods. *Rev. Saude Publica* **2016**, *50* (Suppl. 2), 4s. [CrossRef]
25. Mello, L.A.F.; Tonini, T.; Sousa da Silva, A.; Dutt-Ross, S.; de Souza Velasque, L. Evaluation of primary health care units in the Rio de Janeiro city according to results of pmaq 2012. *J. Ambul. Care Manag.* **2017**, *40*, S71–S82. [CrossRef] [PubMed]
26. Protasio, A.P.L.; Gomes, L.B.; Machado, L.D.S.; Valença, A.M.G. User satisfaction with primary health care by region in Brazil: 1st cycle of external evaluation from PMAQ-AB. Satisfação do usuário da Atenção Básica em Saúde por regiões do Brasil: 1º ciclo de avaliação externa do PMAQ-AB. *Ciência Saúde Coletiva* **2017**, *22*, 1829–1844. [CrossRef] [PubMed]
27. Protasio, A.P.; Gomes, L.B.; Machado, L.D.; Valença, A.M. Factors associated with user satisfaction regarding treatment offered in Brazilian primary health care. *Cad. Saúde Publica* **2017**, *33*, e00184715. [CrossRef]
28. Medeiros, T.M.; Valerio, F.R.; Silva, M.F.B.; Santos, P.L.; Tenório, B.A.; Branco, S.M.C.; Pereira, M.F.; Sá, A.S.; Costa, N.K.A.; Soares, L.C.L.; *el al*. Desafios da universalidade no sus: Avaliação do acesso e qualidade dos serviços de saúde no brasil. *Cad. Pedag.* **2024**, *21*, e5102. [CrossRef]
29. UMANE. Estudo Inédito Revela Percepção Sobre Acesso e Qualidade da Atenção primária à Saúde. Available online: https://biblioteca.observatoriosaudepublica.com.br/blog/saude-publica-no-brasil-atencao-primaria/ (accessed on 9 August 2025).
30. Vital Strategies, UMANE, Universidade Federal de Pelotas, Instituto Devive, Resolve to Save Lives. Mais Dados Mais saúde– Atenção Primária à Saúde. Brasil. 2025. ISBN 978-65-85591-09-6. Available online: https://pesquisa.atlasintel.org (accessed on 8 August 2025).
31. Campos, D.S. Saúde e políticas sociais no rio de janeiro brasil: História, caminhos e tendências. *Cad. Saúde Pública* **2019**, *35*, e00065119. [CrossRef]
32. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico Brasileiro de 2022. Rio de Janeiro, Brazil. 2022. Available online: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/ (accessed on 15 August 2024).
33. Governo do Estado do Rio de Janeiro. *Diagnóstico de saúde da região metropolitana I*; Secretaria de Saúde: Rio de Janeiro, Brazil, 2020.
34. Governo do Estado do Rio de Janeiro. *Diagnóstico de saúde da região metropolitana II*; Secretaria de Saúde: Rio de Janeiro, Brazil, 2020.
35. Governo do Estado do Rio de Janeiro. *Diagnóstico de saúde da região norte*; Secretaria de Saúde: Rio de Janeiro, Brazil, 2020.
36. Governo do Estado do Rio de Janeiro. *Diagnóstico de saúde da região baixada litorânea*; Secretaria de Saúde: Rio de Janeiro, Brazil, 2020.
37. Governo do Estado do Rio de Janeiro. *Diagnóstico de saúde da região médio paraíba*; Secretaria de Saúde: Rio de Janeiro, Brazil, 2020.
38. Governo do Estado do Rio de Janeiro. *Diagnóstico de saúde da região serrana*; Secretaria de Saúde: Rio de Janeiro, Brazil, 2020.
39. Althubaiti, A. Sample size determination: A practical guide for health researchers. *J. Gen. Fam. Med.* **2022**, *24*, 72–78. [CrossRef]
40. Brasil. *Histórico de Cotação*; Banco Central do Brasil: Brasília, Brazil, 2025. Available online: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes (accessed on 15 April 2025).
41. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2019: Informações Sobre Domicílios, Acesso e Utilização dos Serviços de Saúde. IBGE: Rio de Janeiro, Brazil, 2020. Available online: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101748.pdf (accessed on 10 May 2025).
42. Cantalino, J.L.R.; Scherer, M.D.D.A.; Soratto, J.; Schäfer, A.A.; Anjos, D.S.O.D. Satisfação dos usuários em relação aos serviços de Atenção Primária à Saúde no Brasil. *Rev. Saúde Pública* **2021**, *55*, 22. Available online: https://revistas.usp.br/rsp/article/view/186498 (accessed on 17 June 2025). [CrossRef]
43. São Paulo (Estado). Secretaria de Estado da Saúde. Pesquisa de Satisfação dos Usuários do sus/sp. São Paulo, Brazil. 2023. Available online: https://fedap.com.br/2023/09/12/governo-de-sp-lanca-pesquisa-de-satisfacao-dos-usuarios-do-sus-paulista/ (accessed on 10 May 2025).
44. Matta, S.R.; Bertoldi, A.D.; Emmerick, I.C.M.; Fontanella, A.T.; Costa, K.S.; Luiza, V.L. Fontes de obtenção de medicamentos por pacientes diagnosticados com doenças crônicas, usuários do Sistema Único de Saúde. *Cad. Saúde Pública* **2018**, *34*, e00073817. [CrossRef]

45. Oliveira, M.A.; Luiza, V.L.; Tavares, N.U.L.; Mengue, S.S.; Arrais, P.S.D.; Farias, M.R.; Pizzol, T.D.S.D.; Ramos, L.R.; Bertoldi, A.D. Access to medicines for chronic diseases in Brazil: A multidimensional approach. *Rev. Saude Publica* **2016**, *50* (Suppl. 2), 6s. [CrossRef]
46. Lacerda, M.G.C.; Sampaio, J.P.S.; Dourado, C.S.M.E. Percepção Da População Sobre O Papel Do Farmacêutico No Contexto Da Pandemia Do Novo Coronavírus. *Res. Soc. Dev.* **2021**, *10*, e54310918304. [CrossRef]
47. Marinho, L.N.; Campbell, S.M.; Amaral, I.B.S.T.; Reis, R.S.; Godman, B.; Meyer, J.C.; Godói, I.P.D. Public health financing in Brazil (2019–2022): An analysis of the national health fund and implications for health management. *Front. Public Health* **2025**, *13*, 1568351. [CrossRef]
48. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dados Econômico-Financeiros do Setor de Planos de Saúde: 1º Trimestre de 2025. Brasília, Brazil. 2025. Available online: https://www.gov.br/ans (accessed on 10 May 2025).
49. Mahmood, S.; Sequeira, R.; Siddiqui, M.M.U.; Herkenhoff, M.B.A.; Ferreira, P.P.; Fernandes, A.C.; Sousa, P. Decentralization of the health system-experiences from Pakistan, Portugal and Brazil. *Health Res. Policy Syst.* **2024**, *22*, 61. [CrossRef] [PubMed]
50. Santos, R.T.; Franco, T.A.V.; Pitthan, R.G.V.; Cabral, L.M.S.; Cotrim, D.F.; Gomes, B.C. Saúde pública e comunicação: Impasses do SUS à luz da formação democrática da opinião pública. *Ciência Saúde Coletiva* **2022**, *27*, 1547–1556. [CrossRef] [PubMed]
51. Brasil. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003. Dispõe Sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá Outras Providências. Diário Oficial da União, Brasília, Brazil, 1 October 2003. Available online: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm (accessed on 31 August 2025).
52. Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. População Residente Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000–2024-Pactuada pela SES-RJ. Rio de Janeiro, Brazil. 2024. Available online: https://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnetbd/dhx.exe?populacao/pop_populacao_ripsa2024.def (accessed on 10 May 2025).
53. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Pesquisa Nacional de Saúde 2019: Atenção Primária à Saúde e Informações Antropométricas*; IBGE: Rio de Janeiro, Brazil, 2020; Available online: https://www.pns.icict.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/02/liv101758.pdf (accessed on 31 August 2025).
54. Novais, M.; Martins, C.B. Perfil dos Beneficiários de Planos e SUS e o Acesso a Serviços de Saúde–PNAD 2003 e 2008. Instituto de Estudos de Saúde Suplementar-IESS. 2010. Available online: https://www.iess.org.br/sites/default/files/2021-04/TD35.pdf (accessed on 31 August 2025).
55. Ahmed, S.K. Research Methodology Simplified: How to Choose the Right Sampling Technique and Determine the Appropriate Sample Size for Research. *Oral Oncol. Rep.* **2024**, *12*, 100662. [CrossRef]
56. Hulley, S.B.; Cummings, S.R.; Browner, W.S.; Grady, D.G.; Newman, T.B. *Delineando a Pesquisa clínica: Uma Abordagem Epidemiológica*, 4th ed.; Artmed: Porto Alegre, Brazil, 2013.
57. Gil, A.C. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*, 7th ed.; Atlas: São Paulo, Brazil, 2019.
58. Aggarwal, R.; Ranganathan, P. Study designs: Part 2-Descriptive studies. *Perspect. Clin. Res.* **2019**, *10*, 34–36. [CrossRef]

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.